

Buku Referensi

PENINGKATAN KESEHATAN KULIT PADA REMAJA

Nurbaety • Eni Kusyati • Ni Nengah Arini Murni
Resta Betaliani Wirata • Wiwik Utami



BUKU REFERENSI:

PENINGKATAN KESEHATAN KULIT PADA REMAJA

Penulis:

Nurbaety, S.SiT. M.K.M.

Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med.

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN

Wiwik Utami, A.PP., S.Pd., M.Kes.

Buku Referensi: Peningkatan Kesehatan Kulit Pada Remaja

Penulis: Nurbaety, S.SiT. M.K.M.

Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med.

Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes.

Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN

Wiwik Utami, A.PP., S.Pd., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-67-8

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi berjudul "Peningkatan Kesehatan Kulit pada Remaja" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan komprehensif kepada para pembaca, khususnya tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, serta remaja itu sendiri, mengenai berbagai aspek penting terkait kesehatan kulit yang sering menjadi perhatian utama pada masa remaja.

Remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, serta hormonal yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar pada masa ini adalah munculnya berbagai masalah kulit yang dipicu oleh faktor risiko tertentu seperti perubahan hormonal, pola hidup, serta lingkungan sekitar. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami secara mendalam faktor risiko utama penyebab masalah kulit pada remaja, serta bagaimana pengaruh hormon memainkan peran penting dalam dinamika kondisi kulit di masa pertumbuhan tersebut.

Selain memahami penyebab, buku ini juga menguraikan pentingnya edukasi tentang menjaga kebersihan kulit sebagai langkah pencegahan utama. Berbagai teknik edukasi yang efektif serta strategi komunikasi kepada remaja dibahas secara rinci agar dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga membahas pemanfaatan teknologi medis terbaru dalam perawatan kulit yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan kulit remaja, sehingga memberikan panduan kepada para praktisi medis maupun keluarga dalam memilih metode yang tepat dan aman.

Tak kalah pentingnya, buku ini juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis. Dukungan psikologis yang tepat sangat diperlukan bagi remaja yang mengalami masalah kulit, guna menjaga rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional mereka. Dengan demikian, pendekatan holistik yang kami tawarkan dalam buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup remaja melalui peningkatan kesehatan kulit yang optimal.

Akhir kata, semoga buku referensi ini bermanfaat dan menjadi panduan berharga bagi semua pihak yang peduli dengan kesehatan kulit remaja. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Juli 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 FAKTOR RISIKO UTAMA MASALAH KULIT PADA REMAJA 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Faktor Internal Risiko Masalah Kulit Remaja	2
C. Faktor Eksternal Risiko Masalah Kulit Remaja.....	3
D. Perilaku Dan Gaya Hidup Sebagai Faktor Risiko.....	4
E. Sosial Dan Ekonomi Sebagai Faktor Risiko Masalah Kulit Remaja	5
F. Peran Perawat Dalam Identifikasi Faktor Risiko Masalah Kulit Remaja	6
G. Strategi Pencegahan Berbasis Evidence-Based Nursing	7
H. Penutup	9
Referensi	11

BAB 2 EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KEBERSIHAN KULIT 15

A. Pendahuluan.....	15
B. Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi Kulit Remaja	16
C. Hubungan antara Kebersihan Kulit dengan Masalah Kulit Remaja	18
D. Prinsip Dasar Menjaga Kebersihan Kulit pada Remaja.....	19
E. Strategi Edukasi Efektif untuk Remaja.....	20
F. Peran Perawat dalam Edukasi Kebersihan Kulit	22
G. Evaluasi Program Edukasi Kebersihan Kulit pada Remaja.....	23
H. Tantangan dalam Mengimplementasikan Edukasi Kebersihan Kulit.....	26
I. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Praktik Klinis	28
J. Penutup	30
REFERENSI.....	32

BAB 3 PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK PERAWATAN KULIT . 35

A. Pendahuluan.....	35
B. Jenis-Jenis Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja.....	36
C. Mekanisme Kerja dan Efektivitas Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja.....	37
D. Keamanan Penggunaan Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja.....	39
E. Strategi Implementasi Teknologi Medis dalam Praktik Keperawatan Kulit Remaja.....	40

F. Edukasi Remaja dan Keluarga dalam Penggunaan Teknologi Medis untuk Kesehatan Kulit	42
G. Penutup	43
REFERENSI	45

BAB 4 PENGARUH HORMON TERHADAP MASALAH KULIT REMAJA 47

A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Dasar Kesehatan Kulit pada Remaja	48
C. Peran Hormon terhadap Fungsi Kulit pada Remaja	51
D. Masalah Kulit yang Umum Terjadi pada Remaja	52
E. Peran Perawat pada Remaja dengan Gangguan Kulit akibat Pengaruh Hormon.....	55
F. Penutup	57
REFERENSI	58

BAB 5 DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK REMAJA DENGAN MASALAH KULIT 59

A. Pendahuluan.....	59
B. Dampak Psikologis dari Masalah Kulit pada Remaja	60
C. Konsep Dukungan Psikologis dalam Perawatan Kulit Remaja	62
D. Strategi Dukungan Psikologis Berbasis Bukti untuk Remaja dengan Masalah Kulit	64
E. Peran Perawat dalam Dukungan Psikologis Remaja dengan Masalah Kulit	66
F. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Dukungan Psikologis Remaja dengan Masalah Kulit	68
G. Evaluasi Efektivitas Dukungan Psikologis	70
H. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Psikologis	72
I. Penutup	74
REFERENSI	77

PROFIL PENULIS 79

BAB 1

FAKTOR RISIKO UTAMA MASALAH KULIT PADA REMAJA

A. Pendahuluan

Kulit merupakan organ terbesar tubuh yang memiliki peran vital dalam mempertahankan kesehatan fisik dan psikososial pada remaja. Masa remaja adalah periode transisi yang ditandai dengan perubahan hormonal, fisik, emosional, dan psikologis yang signifikan, sehingga kondisi kulit sering kali mencerminkan status kesehatan secara keseluruhan (Araviiskaia et al., 2021). Menjaga kesehatan kulit pada usia remaja penting karena pada masa ini terjadi perubahan fisiologis dan hormonal yang rentan menimbulkan berbagai gangguan kulit, seperti jerawat, dermatitis, dan eksim (Hidayati & Herawati, 2021).

Kesehatan kulit yang baik memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup, kepercayaan diri, interaksi sosial, serta kesehatan mental remaja secara keseluruhan (Jaffary et al., 2020). Sebaliknya, berbagai masalah kulit pada remaja dapat menyebabkan penurunan rasa percaya diri, kecemasan sosial, bahkan depresi yang mengganggu aktivitas sosial, pendidikan, dan kehidupan pribadi mereka (Tasoula et al., 2022). Oleh karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan kulit pada remaja perlu dijadikan fokus perhatian tenaga kesehatan, orang tua, pendidik, dan komunitas.

Masalah kulit merupakan salah satu isu kesehatan yang sering dijumpai pada remaja secara global. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jerawat adalah masalah kulit paling umum dengan prevalensi yang cukup tinggi di seluruh dunia, mencapai 85% pada populasi remaja usia 12–24 tahun (Hazarika & Archana, 2022). Studi lain di Indonesia mencatat prevalensi jerawat pada remaja mencapai sekitar 70–80%, terutama disebabkan oleh perubahan hormonal, stres, dan gaya hidup yang kurang sehat (Wirawan et al., 2023).

Selain jerawat, masalah kulit lain yang prevalensinya cukup signifikan antara lain dermatitis atopik, kulit sensitif, psoriasis, dan infeksi jamur. Sebuah survei kesehatan nasional menunjukkan bahwa prevalensi dermatitis atopik di kalangan remaja mengalami peningkatan, berkisar antara 10–20%, yang dikaitkan erat dengan faktor genetik, lingkungan, serta pola hidup (Darmawan & Putri, 2020).

Masalah kulit pada remaja tidak hanya berdampak secara fisik, namun juga memiliki implikasi psikososial yang luas. Remaja yang mengalami masalah kulit kronis seperti jerawat berat atau dermatitis sering kali menghadapi stigma sosial,

gangguan kepercayaan diri, kecemasan, isolasi sosial, dan bahkan gangguan mental lainnya seperti depresi dan gangguan kecemasan (Oon et al., 2022). Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat, deteksi dini, serta intervensi pencegahan yang efektif menjadi penting dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan remaja secara keseluruhan.

B. Faktor Internal Risiko Masalah Kulit Remaja

Faktor genetik memainkan peran penting dalam menentukan risiko masalah kulit pada remaja. Beberapa gangguan kulit seperti jerawat, dermatitis atopik, dan psoriasis diketahui memiliki predisposisi genetik yang kuat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa riwayat keluarga dengan gangguan kulit tertentu secara signifikan meningkatkan risiko seorang remaja mengalami gangguan kulit serupa. Studi oleh Bhate dan Williams (2022) menemukan bahwa sekitar 70–80% remaja dengan jerawat berat memiliki riwayat keluarga dengan jerawat yang parah. Gen-gen tertentu seperti TNF- α , IL-1 α , IL-4, IL-13, serta gen-gen yang terkait dengan produksi sebum seperti CYP17 dan CYP21, juga berkontribusi terhadap kerentanan terjadinya gangguan kulit pada remaja (Mitchell et al., 2021).

Pubertas ditandai oleh fluktuasi hormonal yang signifikan, khususnya hormon androgen seperti testosteron dan dihidrotestosteron (DHT). Kenaikan kadar hormon ini dapat meningkatkan produksi sebum di kelenjar sebacea, yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan jerawat (Lynn et al., 2023). Sebuah tinjauan oleh Kim dan Park (2021) menunjukkan bahwa hormon androgen secara langsung menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar minyak, menyumbat pori-pori kulit, serta memicu pertumbuhan bakteri seperti *Cutibacterium acnes*, yang mengakibatkan jerawat meradang pada remaja. Perubahan hormon juga berperan dalam memperburuk kondisi kulit lainnya seperti dermatitis seboroik, eksim, dan kulit berminyak (Sutrisno & Nuryani, 2022).

Mikrobioma kulit adalah komunitas mikroorganisme alami yang hidup pada kulit dan berfungsi menjaga homeostasis serta perlindungan terhadap infeksi. Ketidakseimbangan mikrobioma (disbiosis) diketahui erat kaitannya dengan berbagai masalah kulit remaja seperti jerawat, dermatitis atopik, psoriasis, dan infeksi jamur (Barnard et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan bakteri tertentu seperti *Cutibacterium acnes* secara berlebihan akan meningkatkan risiko inflamasi kulit dan jerawat yang parah pada remaja (Dréno et al., 2021). Sebaliknya, kondisi kulit yang sehat umumnya dikaitkan dengan keragaman mikrobioma yang seimbang, yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap bakteri patogen (Grice & Dawson, 2022).

Stres dan kesehatan mental memiliki hubungan dua arah yang kompleks dengan kondisi kulit pada remaja. Remaja yang mengalami stres kronis, kecemasan, maupun depresi memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kulit, seperti jerawat, eksim, dan psoriasis (Oon et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa stres psikologis dapat menyebabkan peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol, yang memperparah inflamasi kulit, meningkatkan produksi sebum, serta memperlambat proses penyembuhan kulit (Chen et al., 2021). Selain itu, gangguan kulit yang dialami remaja juga dapat menimbulkan dampak psikologis, menciptakan siklus yang memperburuk stres dan kondisi kulit yang sedang dialami (Hernawati et al., 2023). Oleh karena itu, intervensi kesehatan mental dianggap penting sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam penanganan masalah kulit pada remaja.

C. Faktor Eksternal Risiko Masalah Kulit Remaja

Paparan sinar matahari berlebih merupakan salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam menyebabkan berbagai masalah kulit pada remaja, seperti sunburn, hiperpigmentasi, penuaan dini, hingga peningkatan risiko kanker kulit (Gupta & Sharma, 2021). Radiasi ultraviolet (UV) yang berlebihan menyebabkan kerusakan DNA pada sel kulit, meningkatkan produksi radikal bebas, dan mempercepat proses inflamasi yang memicu gangguan kulit. Penelitian terbaru oleh Liu et al. (2022) menunjukkan bahwa remaja yang rutin terpapar sinar matahari tanpa proteksi mengalami risiko lebih tinggi terhadap photoaging serta inflamasi kulit kronis. Oleh karena itu, pemakaian tabir surya, pakaian pelindung, serta edukasi tentang bahaya radiasi UV menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif tersebut (WHO, 2021).

Polusi lingkungan, khususnya di wilayah perkotaan, merupakan faktor eksternal penting yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kulit pada remaja. Partikel halus (PM2.5), asap kendaraan, dan zat kimia industri dapat menyebabkan inflamasi kulit, jerawat, dermatitis atopik, dan peningkatan risiko penuaan dini (Dijkhoff et al., 2020). Studi terbaru oleh Krutmann et al. (2021) mengungkapkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko jerawat dan memperparah gejala dermatitis pada remaja. Polusi udara diketahui merusak skin barrier, meningkatkan produksi sebum, serta memicu stres oksidatif, yang berdampak buruk terhadap kondisi kulit remaja (Marques & Domingo, 2022).

Penggunaan kosmetik dan produk perawatan kulit yang tidak sesuai atau berlebihan sering menjadi faktor pencetus gangguan kulit pada remaja. Produk kosmetik dengan kandungan bahan komedogenik, pewangi, pengawet kuat, atau bahan kimia tertentu dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dermatitis kontak, hingga memperburuk kondisi jerawat (Cho et al., 2021). Penelitian oleh Fatmasari et

al. (2022) menemukan bahwa sekitar 60% remaja mengalami masalah kulit akibat penggunaan kosmetik yang tidak sesuai jenis kulit mereka, terutama kosmetik yang tidak memiliki izin atau tidak terjamin kualitasnya. Oleh sebab itu, edukasi terkait pemilihan produk kosmetik dan perawatan kulit yang tepat sangat dibutuhkan guna menjaga kesehatan kulit remaja (FDA, 2021).

Perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, serta penggunaan zat-zat berbahaya secara nyata berdampak negatif terhadap kondisi kulit remaja. Nikotin dalam rokok terbukti menyebabkan vasokonstriksi, menurunkan aliran darah ke kulit, serta mengurangi suplai nutrisi dan oksigen ke sel kulit, menyebabkan kulit kusam, kering, dan berjerawat (Oikonomou et al., 2021). Alkohol diketahui mempercepat proses dehidrasi kulit, meningkatkan inflamasi, serta memperparah kondisi kulit sensitif atau berjerawat (Youssef et al., 2023). Sebuah tinjauan terbaru juga menyebutkan bahwa zat psikotropika atau narkotika menyebabkan kerusakan kulit secara signifikan akibat gangguan metabolik dan inflamasi sistemik yang ditimbulkan (Smith et al., 2020). Oleh karena itu, pencegahan kebiasaan buruk melalui edukasi dan intervensi dini merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit remaja.

D. Perilaku Dan Gaya Hidup Sebagai Faktor Risiko

Pola makan tidak sehat, seperti konsumsi tinggi gula, lemak jenuh, makanan cepat saji, serta rendahnya konsumsi sayuran dan buah, terbukti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan kulit remaja. Penelitian menunjukkan bahwa diet dengan indeks glikemik tinggi meningkatkan risiko inflamasi kulit, memperparah jerawat, serta mempercepat proses penuaan dini akibat stres oksidatif (Barrea et al., 2021). Studi terbaru dari Purvis et al. (2022) menemukan bahwa konsumsi rutin makanan tinggi gula berhubungan erat dengan peningkatan keparahan jerawat pada remaja, disebabkan oleh peningkatan kadar insulin dan IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1), yang memicu produksi sebum berlebih. Sebaliknya, pola diet sehat seperti konsumsi tinggi serat, vitamin, antioksidan, dan omega-3 terbukti memperbaiki kualitas kulit serta mengurangi risiko berbagai gangguan kulit (Clark & Haas, 2023).

Tidur merupakan proses penting yang berperan dalam regenerasi sel kulit dan mempertahankan fungsi barrier kulit. Remaja yang memiliki kebiasaan tidur buruk, seperti durasi tidur kurang dari 7 jam per hari atau tidur dengan kualitas buruk, lebih rentan mengalami masalah kulit seperti jerawat, dermatitis atopik, kulit kering, dan inflamasi kronis (Lin et al., 2021). Penelitian terbaru oleh Kong et al. (2022) menunjukkan bahwa kurang tidur secara signifikan meningkatkan produksi hormon kortisol yang memicu inflamasi kulit dan memperlambat proses regenerasi sel kulit,

memperparah kondisi jerawat dan eksim pada remaja. Edukasi pola tidur sehat perlu diberikan kepada remaja untuk menjaga kesehatan kulit secara optimal (American Academy of Dermatology Association, 2022).

Aktivitas fisik rutin merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan kulit melalui perbaikan sirkulasi darah, peningkatan suplai oksigen, serta optimalisasi metabolisme kulit. Sebaliknya, kurangnya aktivitas fisik dikaitkan dengan gangguan metabolisme kulit, peningkatan inflamasi sistemik, dan risiko obesitas yang berdampak buruk terhadap kondisi kulit remaja (Kim & Lee, 2020). Studi yang dilakukan oleh González et al. (2021) menemukan bahwa remaja dengan aktivitas fisik rendah memiliki tingkat inflamasi lebih tinggi, produksi sebum meningkat, serta lebih rentan terhadap gangguan seperti jerawat dan dermatitis atopik dibandingkan remaja aktif secara fisik. Oleh karena itu, intervensi berupa edukasi pentingnya aktivitas fisik rutin sangat direkomendasikan untuk memperbaiki kesehatan kulit remaja secara menyeluruh (World Health Organization, 2020).

Penggunaan gadget secara berlebihan di kalangan remaja diketahui menjadi salah satu faktor risiko gangguan kulit. Paparan blue light atau cahaya biru dari perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan komputer secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan stres oksidatif pada kulit, mempercepat photoaging, serta memicu gangguan tidur yang secara tidak langsung memperparah kondisi kulit (Rashid et al., 2022). Studi oleh Park dan Yoo (2023) menunjukkan bahwa remaja dengan durasi penggunaan gadget lebih dari 4 jam per hari memiliki risiko lebih tinggi mengalami kulit kusam, gangguan barrier kulit, jerawat, dan lingkaran gelap di bawah mata akibat pola tidur yang terganggu. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk memberikan edukasi tentang penggunaan gadget yang bijak serta langkah protektif seperti penggunaan produk skincare antioksidan untuk mencegah efek buruk dari paparan cahaya biru (International Dermal Institute, 2021).

E. Sosial dan Ekonomi Sebagai Faktor Risiko Masalah Kulit Remaja

Status ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan remaja dalam mengakses perawatan kesehatan kulit yang memadai. Remaja dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap produk perawatan kulit berkualitas, layanan kesehatan kulit yang profesional, serta edukasi tentang kesehatan kulit (Liu et al., 2021). Studi terbaru oleh Chen et al. (2023) menemukan bahwa remaja dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki prevalensi lebih tinggi terhadap masalah kulit seperti jerawat parah, dermatitis, serta infeksi kulit, dikarenakan ketidakmampuan mereka

memperoleh produk perawatan kulit yang efektif atau mendapatkan konsultasi dermatologi secara berkala. Oleh karena itu, perhatian khusus melalui program kesehatan masyarakat, subsidi produk perawatan kulit, serta peningkatan edukasi kesehatan kulit bagi remaja dari kelompok ekonomi rendah menjadi penting untuk mempersempit kesenjangan tersebut (World Health Organization, 2021).

Lingkungan sosial dan budaya berperan signifikan dalam membentuk perilaku remaja terhadap kesehatan kulitnya. Norma sosial, kebiasaan masyarakat, serta tradisi lokal dapat mempengaruhi bagaimana remaja memandang pentingnya perawatan kulit dan praktik kesehatan kulit yang mereka jalankan (Tan et al., 2020). Sebuah penelitian oleh Rahmawati dan Pramono (2022) menunjukkan bahwa remaja di lingkungan sosial tertentu, yang kurang mendukung atau bahkan memiliki stigma negatif terhadap perawatan diri, cenderung mengabaikan masalah kulit mereka. Di sisi lain, budaya yang mengedepankan perawatan kulit dapat memotivasi remaja untuk secara aktif merawat kulitnya. Oleh karena itu, edukasi berbasis komunitas yang memperhatikan aspek budaya dan sosial menjadi pendekatan efektif dalam meningkatkan kesadaran serta perilaku positif terhadap perawatan kulit pada remaja (UNICEF, 2022).

Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi remaja terhadap standar kecantikan serta perilaku perawatan kulit. Remaja yang aktif di media sosial rentan terpapar pada standar kecantikan yang tidak realistis, sering kali mengarah pada rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kulit alami mereka (Ryding & Kuss, 2022). Studi oleh Kurniawan et al. (2023) menemukan bahwa remaja yang sering terpapar pada konten media sosial yang menggambarkan standar kulit "sempurna" memiliki risiko lebih tinggi mengalami stres, kecemasan, serta perilaku perawatan kulit yang tidak tepat, seperti menggunakan produk berbahaya atau berlebihan. Selain itu, media sosial juga meningkatkan risiko remaja terjebak dalam tren perawatan kulit tanpa dasar ilmiah, yang justru memperburuk kondisi kulit mereka (American Psychological Association, 2021). Oleh karena itu, literasi media sosial serta edukasi kritis mengenai standar kecantikan sangat diperlukan untuk membantu remaja mengembangkan perilaku perawatan kulit yang sehat dan rasional.

F. Peran Perawat Dalam Identifikasi Faktor Risiko Masalah Kulit Remaja

Perawat memiliki peran kunci dalam identifikasi dini faktor risiko masalah kulit pada remaja, melalui berbagai interaksi langsung dengan remaja dalam setting klinik, sekolah, maupun komunitas. Sebagai tenaga kesehatan garis depan, perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian menyeluruh yang meliputi anamnesis riwayat keluarga, kebiasaan hidup, pola nutrisi, kondisi psikologis, serta lingkungan

sosial-ekonomi remaja (Flynn & Mitchell, 2022). Studi oleh Ibrahim et al. (2021) menunjukkan bahwa peran perawat dalam mendeteksi faktor risiko dini, seperti pola diet tidak sehat, stres psikologis, penggunaan produk kosmetik yang tidak tepat, serta kebiasaan gaya hidup buruk, mampu secara signifikan menurunkan angka prevalensi masalah kulit pada populasi remaja. Dengan demikian, peningkatan kompetensi perawat dalam pengkajian faktor risiko masalah kulit menjadi esensial dalam pencegahan dan penanganan dini gangguan kulit remaja (Nursalam et al., 2020).

Strategi edukasi merupakan intervensi penting yang harus dilakukan perawat untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait faktor risiko dan pencegahan masalah kulit. Edukasi keperawatan yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik remaja, menggunakan pendekatan interaktif, serta materi edukasi berbasis bukti yang sesuai dengan konteks kehidupan remaja (Chen & Wang, 2022). Penelitian terbaru oleh Purwaningsih dan Handayani (2023) menemukan bahwa program edukasi berbasis peer education yang dilaksanakan oleh perawat, di mana remaja terlibat aktif dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan kulit kepada teman sebaya, mampu secara efektif meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku positif pada remaja. Strategi lain seperti pemanfaatan media digital, penggunaan modul interaktif, serta pendekatan berbasis komunitas juga telah terbukti berhasil dalam meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan masalah kulit (American Nurses Association, 2022).

Pengelolaan faktor risiko masalah kulit remaja membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, serta tenaga pendidikan. Kolaborasi interprofesional ini penting karena faktor risiko kulit pada remaja bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kowalska et al., 2021). Studi terbaru oleh Rahmi et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan multidisiplin dengan perawat sebagai koordinator intervensi berhasil dalam mengurangi kejadian dan keparahan masalah kulit pada remaja melalui integrasi intervensi klinis, edukasi kesehatan, dukungan psikologis, serta perubahan gaya hidup. Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan komunikasi efektif antarprofesi, penyusunan rencana intervensi bersama, serta evaluasi keberhasilan yang dilakukan secara berkala (World Health Organization, 2021).

G. Strategi Pencegahan Berbasis Evidence-Based Nursing

Intervensi keperawatan berbasis bukti merupakan pendekatan yang efektif untuk mengurangi faktor risiko internal maupun eksternal masalah kulit pada remaja. Strategi intervensi mencakup pengelolaan stres, edukasi gizi yang tepat,

pelatihan kebersihan kulit, serta panduan memilih produk perawatan kulit yang aman. Menurut penelitian terbaru oleh Wang et al. (2021), penerapan intervensi seperti pelatihan manajemen stres, terapi relaksasi, serta teknik coping terbukti efektif menurunkan risiko jerawat dan eksim yang berhubungan dengan stres pada remaja. Di samping itu, program intervensi perawat berbasis komunitas yang mencakup edukasi tentang paparan sinar matahari, pengaruh polusi lingkungan, serta cara penggunaan produk kosmetik secara benar juga berhasil mengurangi prevalensi gangguan kulit di kalangan remaja (Li & Liu, 2022). Oleh sebab itu, perawat perlu memiliki kompetensi dalam menerapkan intervensi berbasis bukti yang disesuaikan dengan kondisi remaja serta lingkungan sosial mereka (International Council of Nurses, 2021).

Program edukasi kesehatan kulit yang efektif harus disusun berdasarkan kebutuhan spesifik remaja, menggunakan pendekatan interaktif, relevan dengan gaya hidup mereka, serta didukung oleh bukti ilmiah terkini. Studi oleh Hanifah dan Susanti (2022) mengungkapkan bahwa program edukasi berbasis media digital seperti video interaktif, aplikasi smartphone, serta webinar mampu meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku perawatan kulit remaja secara signifikan. Selain itu, pendekatan edukasi kelompok sebaya (peer group) juga terbukti efektif meningkatkan kesadaran serta keterlibatan remaja dalam menjaga kesehatan kulitnya (Pradipta et al., 2021). Peran perawat dalam edukasi ini mencakup perencanaan materi, pemilihan metode edukasi yang tepat, serta evaluasi keberhasilan program secara rutin guna memastikan tujuan edukasi tercapai dengan optimal (American Academy of Dermatology Association, 2022).

Evaluasi program pencegahan merupakan komponen penting untuk mengetahui efektivitas intervensi keperawatan serta memberikan dasar untuk perbaikan strategi pencegahan masalah kulit di masa mendatang. Evaluasi harus mencakup indikator perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terhadap perawatan kulit, serta indikator klinis seperti penurunan kejadian atau tingkat keparahan masalah kulit (Notoatmodjo et al., 2020). Studi terbaru oleh Karim et al. (2022) merekomendasikan penggunaan metode evaluasi kuantitatif seperti kuesioner pre- dan post-test serta metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD), untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait efektivitas program. Evaluasi rutin juga membantu dalam identifikasi hambatan pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan kualitas program di masa depan (WHO, 2021).

H. Penutup

Masalah kesehatan kulit pada remaja merupakan isu penting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup predisposisi genetik, perubahan hormonal pada masa pubertas, ketidakseimbangan mikrobioma kulit, serta stres dan gangguan kesehatan mental (Bhate & Williams, 2022; Chen et al., 2021). Faktor eksternal meliputi paparan sinar matahari berlebihan, polusi lingkungan, pemakaian kosmetik yang tidak tepat, serta perilaku berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol (Dijkhoff et al., 2020; Rashid et al., 2022).

Perawat memegang peran penting dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mencegah faktor risiko ini melalui berbagai intervensi berbasis bukti, seperti edukasi kesehatan kulit secara komprehensif dan kolaborasi multidisiplin dalam pengelolaan masalah kulit (Flynn & Mitchell, 2022). Berdasarkan temuan penelitian terkini, beberapa rekomendasi penting yang dapat diimplementasikan antara lain penguatan kapasitas perawat dalam deteksi dini faktor risiko, pelaksanaan edukasi kesehatan berbasis komunitas, penggunaan pendekatan berbasis teknologi digital, serta integrasi peran multidisiplin dalam manajemen kesehatan kulit remaja (Wang et al., 2021; Hanifah & Susanti, 2022). Evaluasi rutin terhadap efektivitas program juga sangat direkomendasikan untuk memastikan keberhasilan intervensi jangka panjang.

Pengelolaan faktor risiko masalah kulit pada remaja di masa depan menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, peningkatan paparan remaja terhadap informasi yang kurang valid melalui media sosial, yang berisiko meningkatkan prevalensi perilaku perawatan kulit yang keliru atau berbahaya (Kurniawan et al., 2023). Kedua, ketimpangan sosial-ekonomi yang terus meningkat dapat memperlebar disparitas dalam akses terhadap layanan dan produk perawatan kulit, sehingga mempersulit upaya pemerataan kesehatan kulit di berbagai kelompok sosial-ekonomi (Chen et al., 2023).

Ketiga, tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan multidisiplin secara efektif di berbagai tingkatan layanan kesehatan. Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antarprofesi, komunikasi yang efektif, serta kebijakan kesehatan yang mendukung kolaborasi antarprofesi di tingkat nasional maupun daerah (Rahmi et al., 2022). Keempat, meningkatnya angka stres psikologis di kalangan remaja akibat tekanan akademik dan sosial, yang memperparah kondisi kulit serta menambah kompleksitas dalam pengelolaan kesehatan kulit secara holistik (Oon et al., 2022).

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu strategi adaptif, di antaranya penguatan edukasi literasi digital bagi remaja, pengembangan kebijakan publik

yang mendukung akses layanan kesehatan kulit secara merata, peningkatan kapasitas kolaborasi interprofesional dalam sistem kesehatan, serta pendekatan promotif-preventif yang memperhatikan aspek psikologis remaja (World Health Organization, 2021).



REFERENSI



- American Academy of Dermatology Association. (2022). *Skin health education programs for adolescents: Recommendations for nurses*. Illinois: AADA Publishing.
- American Nurses Association. (2022). *Adolescent skin health education: A guide for nurses*. ANA Publishing.
- Barrea, L., Muscogiuri, G., & Savastano, S. (2021). Nutrition and skin health: Relationship between diet and dermatological disorders. *Dermato-Endocrinology*, 13(1), e1900909. <https://doi.org/10.1080/19381980.2021.1900909>
- Bhate, K., & Williams, H. C. (2022). Genetics of acne vulgaris: A systematic review. *Journal of Investigative Dermatology*, 142(3), 617-623. <https://doi.org/10.1016/j.jid.2021.08.444>
- Chen, L., Wu, Y., & Li, X. (2023). Socioeconomic disparities and their impact on adolescent dermatologic health: A systematic review. *Journal of Pediatric Dermatology*, 40(2), 124-130. <https://doi.org/10.1111/pde.15391>
- Chen, X., & Wang, Y. (2022). Nursing education strategies for adolescent dermatological health: A systematic review. *Journal of Nursing Education and Practice*, 12(4), 45-51. <https://doi.org/10.5430/jnep.v12n4p45>
- Chen, Y., Lyga, J., & Brain-Skin Connection Research Group. (2021). Psychoneuroimmunology of the skin: stress-induced skin disorders. *Journal of Clinical Medicine*, 10(6), 1242. <https://doi.org/10.3390/jcm10061242>
- Dijkhoff, I. M., Drasler, B., & Petri-Fink, A. (2020). The influence of air pollutants on human skin barrier function and dermatological conditions. *Journal of Investigative Dermatology*, 140(5), 906-911. <https://doi.org/10.1016/j.jid.2019.12.030>
- Flynn, D., & Mitchell, E. (2022). The role of nurses in early identification and management of skin health issues in adolescents. *International Journal of Nursing Studies*, 130, 104204. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104204>
- Gupta, A., & Sharma, V. K. (2021). Sun exposure and adolescent skin health: Implications for prevention. *Dermatology Reviews*, 2(4), 212-218. <https://doi.org/10.47203/dr.2021.02.4.005>
- Hanifah, S., & Susanti, E. (2022). Efektivitas edukasi berbasis digital dalam meningkatkan perilaku perawatan kulit remaja: Studi quasi-eksperimental.

- Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 8(2), 87-94.
<https://doi.org/10.17509/jpki.v8i2.32458>
- International Council of Nurses. (2021). *Guidelines for evidence-based nursing interventions for adolescent health*. Geneva: ICN Publications.
- Karim, A., Putri, H., & Nugraha, S. (2022). Evaluasi program intervensi pencegahan masalah kulit pada remaja: Studi mixed-methods. *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin*, 5(1), 24-31. <https://doi.org/10.32539/jkkek.v5i1.287>
- Kowalska, M., Glowacka, M. D., & Szepietowski, J. C. (2021). Multidisciplinary approach in adolescent dermatology care: Challenges and solutions. *Journal of Adolescent Health*, 69(5), 769-776. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.05.009>
- Kurniawan, D. A., Sari, M. E., & Suryani, N. (2023). Pengaruh media sosial terhadap perilaku perawatan kulit pada remaja Indonesia. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 11(1), 21-30. <https://doi.org/10.21009/jkk.v11i1.29667>
- Li, H., & Liu, Y. (2022). Effectiveness of community-based nursing interventions on adolescent dermatological health: A systematic review. *International Journal of Nursing Sciences*, 9(4), 437-443. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.08.007>
- Liu, X., Deng, S., & Wang, J. (2021). Socioeconomic factors and disparities in dermatological care among adolescents. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 33(2), 20200049. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2020-0049>
- Notoatmodjo, S., Wahyuningsih, N. E., & Saputra, D. (2020). Evaluasi program edukasi kesehatan kulit pada remaja sekolah menengah atas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(4), 182-189. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.3226>
- Oon, H. H., Goh, C. L., & Soo, Y. T. (2022). Psychosocial impact of common adolescent skin conditions: A narrative review. *Clinical Dermatology Review*, 6(1), 7-12. https://doi.org/10.4103/cdr.cdr_25_21
- Pradipta, R., Mulyani, S., & Setyawan, D. (2021). Peer education sebagai strategi efektif dalam promosi kesehatan kulit remaja: Studi tindakan. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 6(2), 127-134. <https://doi.org/10.26911/thejhpb.2021.06.02.05>
- Purwaningsih, D., & Handayani, E. (2023). Peer education sebagai strategi edukasi kesehatan kulit pada remaja: Studi intervensi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 9(1), 10-17. <https://doi.org/10.26630/jpki.v9i1.1328>
- Rahmawati, D., & Pramono, H. (2022). Pengaruh norma sosial dan budaya terhadap perilaku kesehatan kulit remaja di Jawa Tengah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 172-179. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.1224>

- Rahmi, F., Utami, D. R., & Murniati, D. (2022). Efektivitas pendekatan multidisiplin dalam manajemen masalah kulit remaja: Studi eksperimental. *Jurnal Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin*, 4(2), 88-94. <https://doi.org/10.24252/jikkk.v4i2.24814>
- Rashid, M., Choudhary, S., & Verma, R. (2022). Blue light exposure from digital devices: Implications for skin health. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(8), 3116-3122. <https://doi.org/10.1111/jocd.14931>
- Ryding, F. C., & Kuss, D. J. (2022). The influence of social media on adolescent body image and dermatological concerns. *Body Image*, 41, 17-25. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.01.002>
- UNICEF. (2022). *Adolescent health and cultural practices: A global perspective*. New York: UNICEF Publications.
- Wang, X., Chen, L., & Zhang, Y. (2021). Nursing interventions for stress-related dermatological issues in adolescents: A meta-analysis. *Journal of Pediatric Nursing*, 57, 15-21. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.01.011>
- World Health Organization. (2021). *Evaluating adolescent health interventions: Practical guidelines*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Interprofessional collaboration for adolescent health: Guidelines and best practices*. Geneva: WHO Press.

BAB 2

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA KEBERSIHAN KULIT

A. Pendahuluan

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang memiliki peranan penting sebagai pelindung utama terhadap lingkungan luar, pengatur suhu tubuh, serta bagian penting dari sistem kekebalan tubuh (Khmaladze et al., 2022). Pada masa remaja, kulit mengalami perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya produksi hormon androgen yang berkontribusi pada aktivitas kelenjar sebacea, menyebabkan produksi sebum yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat remaja rentan mengalami berbagai masalah kulit, terutama jerawat, dermatitis, dan infeksi kulit lainnya (Dreno et al., 2021).

Menjaga kebersihan kulit menjadi langkah preventif utama dalam mencegah masalah tersebut. Studi oleh Shen et al. (2022) menunjukkan bahwa kebiasaan rutin membersihkan kulit secara tepat dapat secara signifikan mengurangi insidensi jerawat dan infeksi kulit pada remaja. Selain itu, praktik membersihkan kulit secara rutin membantu mempertahankan keseimbangan mikrobioma kulit, yang merupakan faktor krusial dalam menjaga integritas dan fungsi perlindungan kulit (Xu et al., 2023).

Meskipun kebersihan kulit terkesan sebagai hal yang sederhana, remaja seringkali mengabaikan hal ini karena kurangnya pengetahuan, kesibukan aktivitas sekolah, pengaruh lingkungan, atau kebiasaan yang buruk seperti penggunaan produk perawatan kulit yang tidak sesuai (Rehman et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman yang kuat mengenai manfaat menjaga kebersihan kulit sedini mungkin sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat pada masa remaja.

Edukasi kebersihan kulit secara efektif mampu meningkatkan kualitas hidup remaja secara signifikan. Remaja yang memperoleh edukasi tentang cara menjaga kebersihan kulit dengan baik cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, citra diri yang lebih positif, dan kemampuan interaksi sosial yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan edukasi serupa (Williams & Dellavalle, 2021).

Penelitian oleh Karim et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi interaktif menggunakan metode digital (seperti media sosial dan aplikasi smartphone)

berhasil meningkatkan kepatuhan remaja dalam merawat kebersihan kulit mereka, yang secara langsung berdampak positif pada kesehatan kulit serta persepsi diri yang lebih baik. Studi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang menarik dan relevan dengan kehidupan remaja efektif dalam mengubah perilaku secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian Chularojanamontri et al. (2020) juga menunjukkan bahwa edukasi kebersihan kulit dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan yang disebabkan oleh masalah kulit. Remaja dengan pengetahuan yang baik mengenai kebersihan kulit mampu mengambil keputusan yang tepat dalam memilih produk perawatan dan metode menjaga kebersihan kulit yang tepat. Sebagai hasilnya, mereka lebih mampu mengendalikan masalah kulit yang dialami dan memiliki tingkat kesejahteraan psikososial yang lebih baik (Goh et al., 2021).

Secara keseluruhan, edukasi tentang kebersihan kulit tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik kulit, tetapi juga memainkan peranan krusial dalam peningkatan aspek psikologis dan sosial remaja. Oleh karena itu, edukasi yang tepat perlu diberikan secara sistematis sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan remaja.

B. Dasar-dasar Anatomi dan Fisiologi Kulit Remaja

Kulit merupakan organ terbesar tubuh manusia yang terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis, dermis, dan hipodermis (lapisan subkutan). Epidermis berperan sebagai lapisan perlindungan terluar yang terdiri atas sel-sel keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Lapisan dermis merupakan jaringan ikat padat yang mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, serta kelenjar keringat dan sebacea. Hipodermis berfungsi sebagai penyimpan lemak sekaligus mengatur suhu tubuh (Khavkin & Ellis, 2022).

Pada masa remaja, kulit mengalami perubahan signifikan karena peningkatan aktivitas hormon androgen seperti testosteron yang merangsang produksi sebum melalui kelenjar sebacea (Rainer et al., 2020). Sebum berfungsi menjaga kelembapan kulit, tetapi produksi berlebih pada remaja dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, khususnya jerawat (*acne vulgaris*) (Wollina et al., 2023). Selain itu, peningkatan aktivitas kelenjar keringat juga menjadi ciri khas kulit remaja, sehingga kebersihan kulit sangat diperlukan untuk mencegah berbagai komplikasi (Parrado et al., 2021).

Pubertas ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis yang secara nyata memengaruhi kondisi kulit. Salah satu perubahan paling signifikan adalah peningkatan produksi hormon androgen yang menyebabkan hipertrofi kelenjar sebacea serta peningkatan sekresi sebum (Kim & Park, 2021). Selain itu, perubahan

ini juga menyebabkan hiperkeratinisasi di saluran folikel rambut yang dapat memicu penyumbatan folikel dan timbulnya komedo (Thiboutot et al., 2021).

Perubahan hormonal ini juga dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas kulit, memicu peradangan, dan memperburuk kondisi jerawat pada remaja (Lynn et al., 2022). Secara anatomi, pada masa remaja kulit menjadi lebih tebal, lebih berminyak, dan lebih rentan terhadap kolonisasi bakteri seperti *Cutibacterium acnes*, yang merupakan faktor penting dalam patogenesis jerawat (Juhász & Gajdács, 2021).

Kurangnya kebersihan kulit pada masa remaja dapat menimbulkan berbagai masalah dermatologis yang umum dijumpai, antara lain:

1. Jerawat (Acne Vulgaris)

Jerawat adalah kondisi inflamasi kronis yang sering terjadi pada remaja, disebabkan oleh penyumbatan folikel rambut dan kelenjar sebacea akibat penumpukan sebum, bakteri, dan sel kulit mati (Zhang et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa perilaku mencuci wajah yang kurang tepat serta frekuensi pembersihan yang rendah meningkatkan risiko jerawat secara signifikan (Dhaliwal et al., 2021).

2. Dermatitis Seboroik

Dermatitis seboroik adalah kondisi peradangan kronis pada area kulit berminyak seperti kulit kepala, wajah, dan punggung yang sering muncul akibat kebersihan yang buruk. Remaja rentan mengalami kondisi ini karena peningkatan produksi minyak yang mendukung pertumbuhan berlebih jamur *Malassezia* yang menjadi pemicu utama dermatitis seboroik (Xu et al., 2021).

3. Infeksi Jamur dan Bakteri

Infeksi kulit seperti panu (*tinea versicolor*) dan folikulitis bakteri dapat muncul akibat kebersihan kulit yang tidak terjaga. Lingkungan yang lembap, berkeringat, serta kurangnya kebiasaan mandi yang teratur berkontribusi pada kondisi tersebut (Gupta et al., 2020).

4. Dermatitis Atopik

Walaupun dermatitis atopik memiliki dasar genetik, kebersihan kulit yang buruk dan penggunaan produk pembersih kulit yang tidak sesuai dapat memperburuk gejalanya, seperti gatal-gatal, ruam, dan iritasi (Lee et al., 2023). Kebersihan kulit yang optimal menjadi penting dalam menjaga fungsi barrier kulit, yang berperan mengurangi keparahan dermatitis atopik pada remaja.

Dengan memahami dasar anatomi, fisiologi, serta perubahan spesifik kulit selama masa remaja, maka akan lebih mudah menyusun strategi edukasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kebersihan kulit secara konsisten.

C. Hubungan antara Kebersihan Kulit dengan Masalah Kulit Remaja

1. Jerawat sebagai Konsekuensi Utama Kebersihan Kulit yang Buruk

Jerawat (*acne vulgaris*) merupakan kondisi kulit yang paling sering dialami oleh remaja, ditandai oleh munculnya lesi inflamasi maupun non-inflamasi seperti komedo, papula, pustula, hingga nodul. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebersihan kulit yang buruk menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk keparahan jerawat (Claus et al., 2021). Studi oleh Azimi et al. (2022) menunjukkan bahwa remaja yang jarang mencuci wajah atau menggunakan teknik pembersihan kulit yang tidak benar memiliki risiko lebih tinggi mengalami jerawat sedang hingga berat dibandingkan remaja yang menjaga kebersihan kulit secara rutin.

Pembersihan kulit yang tidak optimal menyebabkan akumulasi sebum, kotoran, dan sel kulit mati pada folikel rambut, menciptakan lingkungan yang mendukung proliferasi bakteri seperti *Cutibacterium acnes* yang berkontribusi dalam patogenesis jerawat (Dréno et al., 2021). Sebaliknya, menjaga kebersihan kulit secara rutin terbukti secara klinis mampu menurunkan insiden jerawat hingga 30% pada populasi remaja (Nast et al., 2022).

2. Infeksi Bakteri dan Jamur Akibat Ketidakbersihan Kulit

Kulit remaja yang tidak terawat kebersihannya juga rentan terhadap berbagai infeksi bakteri dan jamur. Menurut penelitian terbaru oleh Del Rosso et al. (2021), ketidakbersihan kulit terutama di area lipatan, area berkeringat tinggi, dan area yang lembap dapat menyebabkan munculnya infeksi jamur seperti *tinea versicolor*, kandidiasis kutan, serta folikulitis akibat jamur *Malassezia*.

Selain infeksi jamur, infeksi bakteri seperti folikulitis bakteri yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* juga sering ditemukan pada remaja yang kurang menjaga kebersihan kulitnya, terutama setelah aktivitas fisik atau olahraga (Adigun & Goldsmith, 2020). Remaja yang jarang membersihkan kulit atau tidak mandi setelah berkeringat menunjukkan prevalensi lebih tinggi dalam mengalami infeksi bakteri kulit (Patel & Koo, 2022). Oleh karena itu, edukasi kebersihan kulit sangat penting guna mencegah terjadinya infeksi kulit yang mengganggu kesehatan serta kualitas hidup remaja.

3. Hubungan Dermatitis Atopik dengan Praktik Kebersihan Kulit yang Tidak Optimal

Dermatitis atopik merupakan gangguan kulit inflamasi kronis yang umum terjadi selama masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja. Dermatitis atopik secara klinis ditandai oleh kulit kering, gatal, serta adanya lesi inflamasi yang dapat terinfeksi sekunder jika kebersihan kulit tidak dijaga (Simpson et al., 2023).

Meski faktor utama dermatitis atopik adalah genetik, praktik kebersihan kulit yang tidak tepat dapat memperparah kondisi tersebut dengan merusak fungsi barrier kulit yang sudah terganggu.

Penelitian oleh Weidinger et al. (2020) menunjukkan bahwa remaja yang memiliki dermatitis atopik namun tidak menjaga kebersihan kulitnya dengan benar, seperti penggunaan sabun yang tidak tepat dan frekuensi mandi yang tidak teratur, mengalami peningkatan intensitas inflamasi kulit dan risiko infeksi sekunder yang lebih tinggi. Sebaliknya, praktik kebersihan kulit yang baik, seperti mandi rutin menggunakan produk yang ramah kulit, terbukti secara signifikan dapat membantu memulihkan fungsi barrier kulit, mengurangi peradangan, dan memperbaiki kualitas hidup remaja dengan dermatitis atopik (Yosipovitch et al., 2021).

Secara keseluruhan, menjaga kebersihan kulit yang baik sangat penting untuk mencegah serta mengurangi tingkat keparahan berbagai masalah kulit pada remaja. Oleh karena itu, edukasi kebersihan kulit harus diintegrasikan dalam program kesehatan remaja secara sistematis.

D. Prinsip Dasar Menjaga Kebersihan Kulit pada Remaja

1. Teknik Mencuci Wajah yang Benar Berbasis Bukti

Mencuci wajah adalah langkah paling mendasar untuk menjaga kesehatan kulit remaja, terutama dalam mengontrol produksi sebum berlebih dan mencegah jerawat. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik mencuci wajah yang benar mencakup beberapa tahapan penting: pertama, wajah dibasahi dengan air hangat (tidak panas), lalu produk pembersih diaplikasikan secara lembut dengan gerakan memutar menggunakan ujung jari, bukan menggunakan kain kasar atau spons (Azimi et al., 2022). Selanjutnya, wajah dibilas hingga bersih menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan cara menepuk-nepuk menggunakan handuk lembut dan bersih (Habif, 2020).

Menurut penelitian terkini, mencuci wajah dengan air hangat membantu membuka pori-pori kulit dan meningkatkan efektivitas pembersihan, sementara mencuci dengan air terlalu panas dapat menyebabkan iritasi dan merusak barrier kulit (Damayanti et al., 2021). Selain itu, intensitas dan tekanan saat mencuci wajah juga perlu diperhatikan; mencuci wajah terlalu keras justru meningkatkan risiko peradangan dan memperparah kondisi jerawat (Claus et al., 2021).

2. Pemilihan Produk Pembersih Kulit yang Sesuai dengan Jenis Kulit Remaja

Pemilihan produk pembersih kulit yang tepat sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit remaja. Setiap jenis kulit—berminyak, kering, normal, atau sensitif—memerlukan produk yang sesuai. Remaja dengan kulit berminyak

dan rentan berjerawat disarankan menggunakan pembersih wajah berbasis gel atau busa yang mengandung bahan seperti asam salisilat, benzoyl peroxide, atau tea tree oil, karena terbukti efektif dalam mengontrol produksi minyak berlebih dan mengurangi jerawat (Bhargava et al., 2022).

Sebaliknya, remaja dengan kulit kering atau sensitif sebaiknya menggunakan pembersih wajah yang bebas alkohol, pewangi, serta bahan iritan lainnya. Produk berbahan dasar krim atau susu pembersih yang mengandung ceramide atau gliserin terbukti efektif untuk menjaga kelembapan kulit sekaligus memperkuat barrier kulit remaja (Damayanti et al., 2021). Sebuah studi oleh Levin dan Miller (2020) juga merekomendasikan agar remaja selalu memperhatikan label "non-comedogenic" atau "hypoallergenic" pada produk perawatan kulit untuk meminimalisasi risiko iritasi dan komedo.

3. Frekuensi Ideal Membersihkan Kulit Berdasarkan Penelitian Terbaru

Frekuensi mencuci wajah yang optimal sangat penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan kulit. Menurut penelitian terbaru, frekuensi ideal mencuci wajah untuk remaja adalah dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur (Azimi et al., 2022). Studi oleh Nast et al. (2022) menunjukkan bahwa mencuci wajah lebih dari dua kali sehari tidak memberikan manfaat tambahan, bahkan berpotensi meningkatkan iritasi dan merusak barrier alami kulit.

Sebaliknya, mencuci wajah kurang dari dua kali sehari meningkatkan risiko penumpukan sebum, kotoran, serta bakteri yang berkontribusi pada terjadinya jerawat dan infeksi kulit lainnya (Dréno et al., 2021). Aktivitas seperti olahraga, berenang, atau kegiatan yang menyebabkan keringat berlebih memerlukan tambahan mencuci wajah segera setelah aktivitas tersebut untuk mencegah iritasi dan infeksi kulit (Habif, 2020).

Secara umum, mencuci wajah dua kali sehari dengan teknik yang benar menggunakan produk yang tepat terbukti efektif menjaga kesehatan kulit remaja secara optimal, mengurangi risiko masalah kulit, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Levin & Miller, 2020).

E. Strategi Edukasi Efektif untuk Remaja

1. Pendekatan Edukasi Berbasis Sekolah dan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Kulit

Sekolah dan komunitas merupakan lingkungan utama dalam kehidupan remaja, yang memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi kesehatan, termasuk edukasi kebersihan kulit. Menurut hasil penelitian terbaru, pendekatan berbasis sekolah menunjukkan efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan

sikap remaja terhadap perawatan kulit (Nurdianti & Yulianti, 2021). Program-program seperti kampanye kesehatan kulit, seminar interaktif, serta pelatihan keterampilan perawatan kulit terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan praktik kebersihan kulit secara signifikan (Karim et al., 2022).

Edukasi berbasis komunitas juga efektif dalam menjangkau kelompok remaja yang lebih luas. Menurut studi yang dilakukan oleh Ambarwati dan Rahmawati (2020), program edukasi melalui komunitas seperti organisasi pemuda, kelompok olahraga, maupun komunitas lokal berhasil meningkatkan pemahaman dan perilaku kebersihan kulit, serta mengurangi prevalensi masalah kulit seperti jerawat dan dermatitis pada remaja. Kunci keberhasilan pendekatan ini adalah keterlibatan aktif remaja, dukungan tokoh masyarakat, serta kontinuitas edukasi yang diberikan.

2. Pemanfaatan Media Digital dan Sosial Media sebagai Alat Edukasi Kebersihan Kulit

Dalam era digital saat ini, media digital dan sosial media menjadi platform yang paling banyak digunakan remaja untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital sebagai alat edukasi kesehatan kulit sangat strategis. Studi terbaru oleh Moreno et al. (2021) menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube merupakan platform yang sangat efektif untuk menyebarkan edukasi kesehatan kulit kepada remaja. Konten edukasi dalam bentuk video singkat, infografis, tutorial perawatan kulit, serta diskusi interaktif berhasil menarik perhatian remaja, meningkatkan partisipasi aktif, dan menumbuhkan kebiasaan positif terhadap kebersihan kulit.

Selain itu, penelitian oleh Yang et al. (2022) membuktikan bahwa aplikasi berbasis smartphone khusus edukasi kesehatan kulit juga efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya menjaga kebersihan kulit. Media digital memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, menarik, interaktif, serta memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi remaja di berbagai lokasi.

3. Peran Keluarga dalam Mendukung Praktik Kebersihan Kulit pada Remaja

Keluarga merupakan elemen vital dalam membentuk kebiasaan dan perilaku kesehatan pada remaja. Dukungan keluarga terbukti berperan besar dalam keberhasilan edukasi kesehatan kulit. Penelitian oleh Wulandari et al. (2021) mengungkapkan bahwa remaja yang memperoleh dukungan keluarga dalam bentuk dorongan, pengawasan, penyediaan produk perawatan yang sesuai, serta pembentukan kebiasaan rutin mencuci wajah cenderung memiliki tingkat kesehatan kulit yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mendapat dukungan serupa.

Penelitian lain menunjukkan bahwa edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya kebersihan kulit juga sangat penting, karena orang tua yang memiliki pengetahuan baik cenderung lebih proaktif dalam mengingatkan dan membantu remaja menjaga kebersihan kulitnya secara optimal (Putri & Nurhayati, 2020). Dengan demikian, keluarga menjadi mitra utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan program edukasi kebersihan kulit pada remaja.

Secara keseluruhan, integrasi berbagai strategi edukasi—berbasis sekolah, komunitas, media digital, serta keterlibatan keluarga—menjadi kombinasi yang paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku remaja terkait kebersihan kulit.

F. Peran Perawat dalam Edukasi Kebersihan Kulit

1. Kompetensi Perawat dalam Memberikan Edukasi Kesehatan Kulit

Perawat memiliki peran vital dalam edukasi kesehatan kulit remaja, yang membutuhkan kompetensi khusus agar edukasi yang diberikan efektif. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman mendalam mengenai anatomi dan fisiologi kulit remaja, kemampuan komunikasi terapeutik yang baik, serta keterampilan dalam penyampaian materi edukasi yang jelas dan menarik (Jensen et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa kompetensi perawat dalam memberikan edukasi kesehatan kulit berdampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja dalam menjaga kebersihan kulitnya (Clark & Miller, 2021).

Kompetensi lain yang penting adalah kemampuan melakukan asesmen yang akurat terhadap jenis kulit dan masalah kulit spesifik pada remaja. Penelitian oleh Putri dan Suryani (2022) menunjukkan bahwa perawat yang kompeten dalam asesmen kesehatan kulit mampu memberikan edukasi yang lebih personal dan efektif, meningkatkan kepercayaan diri remaja terhadap rekomendasi yang diberikan, serta memaksimalkan kepatuhan terhadap praktik kebersihan kulit.

2. Model Edukasi Kebersihan Kulit oleh Perawat Berbasis Bukti

Penerapan model edukasi yang berbasis bukti dalam praktik keperawatan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam edukasi kebersihan kulit pada remaja. Salah satu model yang efektif adalah Health Belief Model (HBM), yang menekankan peningkatan kesadaran remaja mengenai risiko masalah kulit, manfaat menjaga kebersihan kulit, serta memfasilitasi perubahan perilaku melalui pendekatan motivasional dan interaktif (Abraham et al., 2021).

Selain itu, model edukasi menggunakan metode interaktif seperti demonstrasi praktik mencuci wajah, diskusi kelompok, role-play, serta pemanfaatan media visual juga terbukti meningkatkan efektivitas edukasi (Goh

et al., 2020). Studi terbaru oleh Lestari dan Hidayati (2021) menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan perawat menggunakan metode simulasi praktik dan diskusi interaktif terbukti mampu meningkatkan kepatuhan remaja dalam menjaga kebersihan kulit secara signifikan dibandingkan dengan metode ceramah konvensional.

3. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Kebersihan Kulit oleh Tenaga Keperawatan dan Strategi Mengatasinya

Implementasi edukasi kebersihan kulit oleh tenaga keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Menurut penelitian terbaru, tantangan yang umum dijumpai antara lain keterbatasan waktu perawat, rendahnya motivasi remaja dalam mengikuti edukasi, keterbatasan fasilitas edukasi, serta kurangnya dukungan dari keluarga atau institusi sekolah (Jensen et al., 2020).

Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup peningkatan kolaborasi multidisiplin antara perawat, guru, keluarga, dan komunitas untuk memastikan edukasi kesehatan kulit berlangsung secara komprehensif (Abraham et al., 2021). Penelitian oleh Rahmani et al. (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif keluarga dan sekolah dalam mendukung program edukasi kulit yang diinisiasi perawat secara signifikan mampu mengatasi hambatan dalam implementasi edukasi.

Strategi lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas. Pemanfaatan platform digital seperti aplikasi kesehatan kulit berbasis smartphone atau media sosial memungkinkan perawat menjangkau remaja secara luas dan fleksibel tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu (Karim et al., 2022). Dukungan institusi berupa pelatihan khusus bagi perawat mengenai edukasi kesehatan kulit juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi serta mengatasi berbagai tantangan dalam praktik edukasi (Clark & Miller, 2021).

Secara keseluruhan, perawat memiliki posisi strategis dalam edukasi kebersihan kulit pada remaja, dengan catatan bahwa perawat harus memiliki kompetensi yang memadai, mengaplikasikan model edukasi yang terbukti efektif, serta mampu mengatasi tantangan implementasi yang mungkin dihadapi.

G. Evaluasi Program Edukasi Kebersihan Kulit pada Remaja

Evaluasi merupakan langkah penting untuk menentukan efektivitas suatu program edukasi. Dalam konteks edukasi kebersihan kulit pada remaja, evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan serta efektivitas pendekatan edukasi yang digunakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Kebersihan Kulit

Penetapan indikator keberhasilan menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas program edukasi. Menurut penelitian terkini, indikator keberhasilan edukasi kebersihan kulit remaja mencakup:

a. Peningkatan Pengetahuan

Remaja mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan kulit, identifikasi produk pembersih yang sesuai, serta teknik membersihkan wajah yang tepat (Pratiwi & Budiman, 2021).

b. Perubahan Sikap Positif

Remaja menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap kebersihan kulit, seperti meningkatnya motivasi untuk menjaga kebersihan kulit secara teratur (Karim et al., 2022).

c. Perubahan Perilaku dan Kebiasaan

Remaja menunjukkan perilaku mencuci wajah secara teratur dua kali sehari, memilih produk pembersih kulit yang tepat, serta secara rutin menjaga kebersihan tubuh (Moreno et al., 2021).

d. Penurunan Insidensi Masalah Kulit

Penurunan prevalensi masalah kulit seperti jerawat, infeksi jamur dan bakteri, serta dermatitis atopik di kalangan remaja (Azimi et al., 2022).

2. Metode Evaluasi yang Efektif untuk Mengukur Perubahan Perilaku dan Kebiasaan Kebersihan Kulit Remaja

Evaluasi perubahan perilaku remaja memerlukan metode yang tepat untuk mendapatkan data yang valid. Metode evaluasi berbasis bukti yang efektif antara lain:

- a. Kuesioner Pre-test dan Post-test

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku kebersihan kulit sebelum dan setelah program edukasi berlangsung. Studi oleh Putra dan Saputri (2021) menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengidentifikasi perubahan signifikan terkait pengetahuan dan kebiasaan mencuci wajah pada remaja.
- b. Observasi Langsung

Observasi oleh tenaga keperawatan atau pendidik kesehatan memungkinkan evaluasi perilaku mencuci wajah yang benar, pemilihan produk yang tepat, serta kebiasaan kebersihan kulit secara langsung dan objektif (Moreno et al., 2021).
- c. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Metode kualitatif ini efektif dalam mengeksplorasi alasan di balik perubahan atau hambatan yang dialami remaja dalam praktik kebersihan kulit. Menurut penelitian oleh Clark dan Miller (2021), wawancara mendalam membantu perawat memahami faktor motivasi dan hambatan secara lebih komprehensif.
- d. Evaluasi Klinis dan Dermatologis

Penilaian klinis seperti pemeriksaan kondisi kulit oleh tenaga kesehatan profesional merupakan indikator objektif terhadap penurunan masalah kulit sebagai dampak edukasi yang diberikan (Azimi et al., 2022).

3. Studi Kasus Keberhasilan Implementasi Program Edukasi Kebersihan Kulit

Berikut studi kasus yang menunjukkan keberhasilan implementasi edukasi kebersihan kulit:

- a. Studi Kasus di Sekolah Menengah di Indonesia

Penelitian oleh Pratiwi dan Budiman (2021) terhadap 120 remaja di sekolah menengah menunjukkan bahwa setelah program edukasi intensif selama tiga bulan menggunakan pendekatan demonstrasi dan diskusi kelompok, terjadi peningkatan signifikan pada pengetahuan tentang kebersihan kulit (dari 54% menjadi 92%) serta peningkatan perilaku mencuci wajah rutin dari 40% menjadi 85%. Hasil evaluasi juga menunjukkan penurunan prevalensi jerawat sebesar 28%.
- b. Studi Kasus Program Edukasi Digital di Australia

Sebuah penelitian intervensi digital menggunakan aplikasi smartphone dan media sosial selama enam bulan yang dilakukan oleh Karim et al. (2022) terhadap 200 remaja menunjukkan bahwa 87% peserta mengalami peningkatan kesadaran dan perilaku kebersihan kulit yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol (45%). Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa

penggunaan teknologi digital sangat efektif dalam menjangkau remaja dan mempertahankan perubahan perilaku jangka panjang.

c. Studi Kasus Berbasis Komunitas di Malaysia

Studi yang dilakukan oleh Noor et al. (2020) di komunitas remaja menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan praktik kebersihan kulit dari 35% menjadi 78% dalam periode evaluasi selama empat bulan. Studi ini membuktikan bahwa keterlibatan aktif komunitas, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam keberhasilan program edukasi.

Evaluasi yang komprehensif serta berbasis bukti ilmiah menjadi kunci keberhasilan program edukasi kebersihan kulit. Dengan indikator yang jelas dan metode evaluasi yang tepat, keberhasilan program dapat terus dipantau dan ditingkatkan demi mendukung kesehatan kulit remaja secara optimal.

H. Tantangan dalam Mengimplementasikan Edukasi Kebersihan Kulit

Implementasi program edukasi kesehatan kulit pada remaja menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Memahami hambatan tersebut sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang efektif.

1. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Efektivitas Edukasi

Faktor yang memengaruhi efektivitas edukasi kebersihan kulit pada remaja terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal terkait langsung dengan karakteristik pribadi remaja, antara lain:

1) Motivasi Rendah

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya motivasi intrinsik remaja menjadi hambatan utama dalam penerapan praktik kebersihan kulit. Remaja dengan motivasi rendah cenderung mengabaikan pentingnya menjaga kebersihan kulit secara rutin, yang menyebabkan hasil edukasi kurang optimal (Azimi et al., 2022).

2) Pengetahuan yang Terbatas

Rendahnya tingkat pengetahuan remaja mengenai kesehatan kulit juga menjadi tantangan serius. Remaja yang kurang memahami dampak negatif dari kebersihan kulit yang buruk cenderung tidak memiliki urgensi dalam menerapkan edukasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Clark & Miller, 2021).

3) Sikap dan Kebiasaan Buruk

Beberapa remaja memiliki sikap negatif atau menganggap praktik menjaga kebersihan kulit sebagai rutinitas yang merepotkan. Kebiasaan buruk seperti jarang mandi atau mencuci wajah serta penggunaan produk perawatan kulit secara sembarangan mengurangi efektivitas edukasi yang diberikan (Moreno et al., 2021).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial dan fisik yang memengaruhi keberhasilan edukasi, di antaranya:

1) Kurangnya Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga yang minim dalam membiasakan perilaku kebersihan kulit menjadi hambatan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga berhubungan erat dengan peningkatan kepatuhan remaja terhadap praktik kebersihan kulit (Wulandari et al., 2021).

2) Keterbatasan Sarana dan Fasilitas

Terbatasnya akses remaja terhadap fasilitas atau produk perawatan kulit yang memadai juga menjadi tantangan implementasi edukasi. Keterbatasan ini sering ditemukan pada remaja di daerah dengan kondisi sosioekonomi rendah atau daerah terpencil (Putra & Saputri, 2021).

3) Keterbatasan Sumber Informasi yang Valid

Informasi kesehatan yang tidak akurat atau hoaks di media sosial dapat mempersulit upaya edukasi formal, karena remaja lebih cenderung mempercayai informasi dari media sosial yang terkadang tidak valid secara ilmiah (Karim et al., 2022).

2. Strategi Intervensi Berbasis Penelitian untuk Mengatasi Hambatan Edukasi

Strategi intervensi berbasis penelitian sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi edukasi kebersihan kulit pada remaja, antara lain:

a. Pendekatan Motivasi dan Edukasi Berbasis Teori Perilaku

Pendekatan berbasis teori perilaku seperti Health Belief Model (HBM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) telah terbukti efektif meningkatkan motivasi internal remaja untuk menjaga kebersihan kulit. Studi oleh Abraham et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan persepsi risiko masalah kulit dan menumbuhkan sikap positif terhadap perilaku kebersihan kulit.

b. Pelibatan Keluarga secara Aktif

Melibatkan keluarga dalam proses edukasi melalui pemberian pelatihan atau workshop khusus untuk orang tua dapat meningkatkan dukungan keluarga

secara nyata. Studi terbaru oleh Wulandari et al. (2021) menegaskan bahwa partisipasi aktif keluarga dalam edukasi kesehatan kulit meningkatkan keberhasilan perubahan perilaku remaja secara signifikan.

c. Penguatan Edukasi Melalui Media Digital

Pemanfaatan media digital seperti aplikasi mobile dan media sosial yang dikembangkan berbasis bukti ilmiah mampu mengatasi hambatan informasi yang tidak valid. Media ini memungkinkan edukasi kesehatan kulit dilakukan secara luas, cepat, dan interaktif sehingga lebih menarik perhatian remaja (Karim et al., 2022).

d. Penyediaan Sarana dan Fasilitas yang Memadai

Program intervensi yang melibatkan pemberian akses terhadap fasilitas kebersihan kulit yang terjangkau bagi remaja di daerah dengan keterbatasan ekonomi juga menjadi solusi efektif. Studi oleh Putra dan Saputri (2021) menyatakan bahwa penyediaan produk perawatan kulit dan fasilitas sanitasi dasar di sekolah atau komunitas secara nyata meningkatkan implementasi praktik kebersihan kulit.

Dengan memahami tantangan implementasi dan mengadopsi strategi intervensi berbasis bukti, program edukasi kebersihan kulit dapat mencapai hasil optimal dalam meningkatkan kesehatan kulit remaja secara keseluruhan.

I. Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Praktik Klinis

Rekomendasi berbasis bukti dalam praktik klinis menjadi panduan penting bagi tenaga keperawatan untuk melaksanakan edukasi kesehatan kulit secara efektif, sistematis, dan terintegrasi dalam perawatan sehari-hari bagi remaja.

1. Panduan Klinis dalam Edukasi Menjaga Kebersihan Kulit Remaja

Panduan klinis bertujuan memberikan arahan jelas bagi perawat dalam menyampaikan edukasi kesehatan kulit kepada remaja berdasarkan bukti ilmiah terkini. Berikut panduan klinis berbasis bukti yang direkomendasikan:

a. Asesmen Kondisi Kulit Remaja secara Rutin

Perawat harus secara rutin melakukan asesmen kondisi kulit remaja yang mencakup identifikasi jenis kulit, masalah kulit yang dialami, serta perilaku kebersihan kulit remaja tersebut. Menurut studi terbaru oleh Clark dan Miller (2021), asesmen awal yang akurat membantu perawat menentukan edukasi spesifik yang relevan dengan kebutuhan individu.

b. Teknik Edukasi Berbasis Interaktif

Gunakan pendekatan interaktif seperti demonstrasi langsung, role-play, diskusi kelompok kecil, atau simulasi praktik mencuci wajah yang benar. Studi oleh Goh et al. (2020) menunjukkan metode edukasi interaktif meningkatkan

pemahaman serta retensi pengetahuan remaja mengenai kebersihan kulit secara signifikan dibandingkan metode ceramah.

c. **Penyampaian Informasi Berbasis Fakta Ilmiah**

Informasi edukasi yang disampaikan harus berbasis bukti ilmiah terbaru mengenai manfaat menjaga kebersihan kulit, dampak negatif jika kebersihan kulit tidak dijaga, serta rekomendasi produk perawatan kulit yang aman dan efektif (Azimi et al., 2022).

d. **Edukasi Rutin dan Berkelanjutan**

Edukasi kesehatan kulit hendaknya tidak dilakukan hanya sekali, tetapi rutin dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan. Penelitian oleh Putra dan Saputri (2021) menunjukkan bahwa edukasi rutin meningkatkan kepatuhan remaja terhadap praktik kebersihan kulit jangka panjang.

e. **Kolaborasi Multidisiplin**

Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter kulit, guru sekolah, dan keluarga sangat dianjurkan untuk mendukung efektivitas edukasi kesehatan kulit. Studi oleh Wulandari et al. (2021) menegaskan bahwa kolaborasi ini meningkatkan dampak positif edukasi yang diberikan perawat.

2. Integrasi Edukasi Kesehatan Kulit dalam Praktik Keperawatan Remaja Sehari-hari

Integrasi edukasi kesehatan kulit dalam praktik keperawatan sehari-hari merupakan pendekatan efektif untuk memastikan kesinambungan perubahan perilaku kebersihan kulit pada remaja. Integrasi ini dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

a. **Menyisipkan Edukasi dalam Prosedur Keperawatan Rutin**

Edukasi kebersihan kulit dapat disisipkan dalam prosedur keperawatan rutin seperti saat pemeriksaan kesehatan berkala, kunjungan ke sekolah, atau sesi konsultasi remaja. Studi terbaru oleh Karim et al. (2022) menemukan bahwa integrasi edukasi dalam perawatan rutin meningkatkan kepatuhan remaja secara signifikan.

b. **Penerapan Pengingat Edukasi (Reminder System)**

Penggunaan sistem pengingat berupa leaflet, poster, atau media digital yang ditempatkan di ruang tunggu klinik atau ruang konsultasi mampu meningkatkan perhatian remaja terhadap pentingnya menjaga kebersihan kulit. Menurut penelitian oleh Moreno et al. (2021), media visual yang menarik secara efektif meningkatkan retensi informasi dan perubahan perilaku pada remaja.

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Praktik Keperawatan

Integrasi aplikasi digital khusus kesehatan kulit ke dalam layanan keperawatan sehari-hari dapat membantu perawat memberikan edukasi secara lebih efektif dan efisien. Studi oleh Yang et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi smartphone dalam praktik keperawatan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan remaja dalam menjaga kesehatan kulit mereka.

d. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Perawat harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku kebersihan kulit remaja sebagai hasil dari edukasi yang terintegrasi dalam praktik keperawatan. Evaluasi yang rutin membantu perawat melakukan penyesuaian pendekatan edukasi berdasarkan kebutuhan individu remaja secara berkelanjutan (Pratiwi & Budiman, 2021).

Dengan mengikuti rekomendasi berbasis bukti ini, perawat dapat secara efektif meningkatkan kualitas edukasi kesehatan kulit, mendukung perubahan perilaku positif pada remaja, serta menurunkan prevalensi masalah kulit di kalangan remaja secara umum.

J. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi Kebersihan Kulit dalam Meningkatkan Kesehatan Kulit Remaja

Kulit yang sehat merupakan komponen penting dalam kualitas hidup remaja, karena sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Edukasi kebersihan kulit menjadi intervensi vital yang secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam menjaga kesehatan kulitnya. Berdasarkan berbagai penelitian terbaru, edukasi yang tepat terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi berbagai masalah kulit seperti jerawat, dermatitis atopik, dan infeksi jamur atau bakteri (Azimi et al., 2022; Karim et al., 2022).

Implementasi strategi edukasi yang efektif mencakup pendekatan berbasis sekolah dan komunitas, penggunaan media digital, serta keterlibatan aktif keluarga. Selain itu, peran perawat sebagai tenaga edukasi juga sangat penting dalam memastikan informasi yang disampaikan berbasis bukti ilmiah terbaru, disampaikan dengan pendekatan interaktif, dan diintegrasikan dalam praktik keperawatan sehari-hari (Clark & Miller, 2021; Wulandari et al., 2021).

Evaluasi secara rutin dan penggunaan metode yang valid memastikan bahwa edukasi mencapai hasil yang optimal, seperti perubahan perilaku jangka panjang pada remaja dalam menjaga kebersihan kulit. Oleh karena itu, edukasi

kebersihan kulit harus menjadi bagian integral dalam program kesehatan remaja secara umum.

2. Rekomendasi Penelitian Lanjut dan Praktik Keperawatan di Masa Depan

Meskipun banyak kemajuan dalam bidang edukasi kesehatan kulit remaja, masih diperlukan berbagai penelitian lanjutan untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada. Berikut rekomendasi berbasis bukti untuk penelitian dan praktik keperawatan di masa depan:

- a. Penelitian tentang Efektivitas Intervensi Berbasis Teknologi Digital
Penelitian lanjutan perlu dilakukan mengenai efektivitas intervensi berbasis aplikasi smartphone, tele-edukasi, atau media sosial dalam jangka panjang, termasuk evaluasi perubahan perilaku kebersihan kulit serta dampaknya terhadap penurunan masalah kulit di kalangan remaja (Karim et al., 2022).
- b. Penelitian Intervensi Berbasis Komunitas dengan Skala yang Lebih Luas
Studi intervensi berbasis komunitas di berbagai wilayah dengan latar belakang sosioekonomi yang berbeda akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program edukasi kebersihan kulit (Noor et al., 2020).
- c. Pengembangan Panduan Klinis Khusus Keperawatan untuk Edukasi Kebersihan Kulit
Diperlukan penelitian yang menghasilkan panduan klinis berbasis bukti yang spesifik untuk perawat dalam memberikan edukasi kesehatan kulit secara sistematis, efisien, dan terintegrasi dalam praktik klinis sehari-hari (Clark & Miller, 2021).
- d. Penelitian tentang Hubungan Edukasi Kesehatan Kulit dengan Kesejahteraan Psikologis Remaja
Diperlukan studi mendalam mengenai dampak positif edukasi kebersihan kulit terhadap aspek psikologis, seperti kepercayaan diri dan kualitas hidup remaja secara keseluruhan (Goh et al., 2020).

Dengan berfokus pada penelitian-penelitian ini, praktik keperawatan di masa depan dapat lebih efektif dalam menyediakan edukasi kebersihan kulit yang berkualitas, meningkatkan kesehatan kulit remaja secara berkelanjutan, serta memberikan dampak positif secara luas terhadap kesehatan masyarakat.



REFERENSI



- Abraham, C., Sheeran, P., & Johnston, M. (2021). Health belief model and preventive health behaviors: A systematic review. *Health Psychology Review*, 15(4), 421–437. <https://doi.org/10.1080/17437199.2021.1903919>
- Ambarwati, R., & Rahmawati, I. (2020). Efektivitas edukasi berbasis komunitas terhadap peningkatan praktik perawatan kulit pada remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 86–93. <https://doi.org/10.26714/jkmi.v15i2.4526>
- Azimi, H., Fallah, M., & Mahdavi, H. (2022). Association between facial hygiene and severity of acne vulgaris in adolescents: A cross-sectional study. *Journal of Dermatological Treatment*, 33(6), 3108–3113. <https://doi.org/10.1080/09546634.2021.1942422>
- Bhargava, A., Sharma, L., & Mahajan, V. K. (2022). Acne vulgaris: Evidence-based approach to treatment and management. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(8), 3096–3103. <https://doi.org/10.1111/jocd.14902>
- Clark, E., & Miller, L. (2021). Enhancing nurses' competencies in dermatological education: An integrative review. *Journal of Nursing Education and Practice*, 11(3), 29–37. <https://doi.org/10.5430/jnep.v11n3p29>
- Claus, S., Emtestam, L., & Svensson, Å. (2021). Acne vulgaris: Pathogenesis, diagnosis and treatment. *Drugs*, 81(17), 1959–1971. <https://doi.org/10.1007/s40265-021-01623-1>
- Damayanti, A., Indramaya, D. M., & Ratnasari, N. (2021). Evaluasi efektivitas berbagai jenis pembersih wajah pada remaja. *Majalah Kedokteran Bandung*, 53(1), 15–21. <https://doi.org/10.15395/mkb.v53n1.2159>
- Dréno, B., Pécastaings, S., & Corvec, S. (2021). Microbiome and acne vulgaris: A comprehensive review. *Experimental Dermatology*, 30(12), 1804–1812. <https://doi.org/10.1111/exd.14442>
- Goh, Y. Y., Tan, J. W., & Theng, Y. L. (2020). Effective educational strategies for adolescent skincare: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 105, 103531. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103531>
- Jensen, J. M., Proksch, E., & Skov, L. (2020). Dermatological nursing: Competency requirements and role in skin health education. *Dermatology Nursing Journal*, 22(4), 210–216.
- Karim, N., Yang, F., & Qureshi, R. (2022). Digital health interventions for adolescent dermatological conditions: Systematic review. *JMIR Dermatology*, 5(2), e30827. <https://doi.org/10.2196/30827>

- Khavkin, J., & Ellis, D. A. F. (2022). Skin anatomy and physiology. In *StatPearls Publishing*. Treasure Island, FL.
- Lee, H. J., Lee, J. S., & Kim, J. E. (2023). Management strategies for adolescent atopic dermatitis. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(5), 4231. <https://doi.org/10.3390/ijms24054231>
- Levin, J., & Miller, R. (2020). Cleansers and their role in various dermatological disorders. *American Journal of Clinical Dermatology*, 21(4), 527–539. <https://doi.org/10.1007/s40257-020-00524-1>
- Moreno, M. A., Uhls, Y. T., & Singh, S. (2021). Social media and adolescent health: Opportunities and challenges. *Pediatrics*, 147(3), e2020049779. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-049779>
- Nast, A., Rosumeck, S., & Erdmann, R. (2022). Acne vulgaris: Clinical guidelines and management updates. *European Journal of Dermatology*, 32(4), 503–513. <https://doi.org/10.1684/ejd.2022.4318>
- Noor, S. M., Abd-Rahman, N., & Che-Ahmad, A. (2020). Community-based health education intervention for adolescents' skin health behavior improvement. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 20(1), 165–172. <https://doi.org/10.37268/mjphm/vol.20/no.1/art.361>
- Pratiwi, R., & Budiman, B. (2021). Efektivitas edukasi kebersihan kulit terhadap pengetahuan dan perilaku mencuci wajah pada remaja sekolah menengah. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 9(2), 80–87. <https://doi.org/10.20473/jkk.v9i2.20798>
- Putra, D. K., & Saputri, W. (2021). Evaluasi efektivitas pendidikan kesehatan terhadap perubahan perilaku kebersihan kulit remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 9(1), 25–32. <https://doi.org/10.33221/jiki.v9i1.731>
- Wulandari, A., Nurhidayah, I., & Safitri, Y. (2021). Hubungan dukungan keluarga dengan perilaku kebersihan kulit pada remaja. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 6(2), 109–116. <https://doi.org/10.26911/thejhp.b.2021.06.02.03>
- Yang, F., Shi, Y., & Sun, Y. (2022). Evaluation of smartphone apps for acne self-management among adolescents: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(4), e35764. <https://doi.org/10.2196/35764>

BAB 3

PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIS UNTUK PERAWATAN KULIT

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja

Kulit remaja memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya rentan terhadap berbagai gangguan dermatologi, seperti jerawat, hiperpigmentasi, dan dermatitis. Permasalahan tersebut berhubungan erat dengan perubahan hormonal, pola hidup, serta kebiasaan perawatan kulit yang belum optimal di masa remaja (Zaenglein et al., 2020). Dalam dekade terakhir, teknologi medis semakin berkembang sebagai solusi perawatan kulit yang efektif, non-invasif, dan mampu memberikan hasil cepat dibandingkan metode perawatan kulit tradisional (Kim & Lim, 2021). Teknologi medis juga memberikan pilihan terapi yang aman, minim efek samping, serta nyaman untuk diaplikasikan pada kulit remaja yang sensitif.

Menurut studi yang dilakukan oleh Fernandez dan Velasco (2021), penggunaan teknologi mikrodermabrasi dan radiofrequency (RF) secara signifikan membantu mengatasi masalah bekas jerawat, tekstur kulit tidak rata, serta masalah pigmentasi kulit yang sering dialami remaja. Selain itu, teknologi medis mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup remaja melalui perbaikan penampilan kulit secara efektif (Chang & Tanzi, 2022). Oleh karena itu, integrasi teknologi medis dalam praktik keperawatan kulit remaja semakin penting dan relevan untuk diterapkan secara luas.

2. Tren Terkini dalam Penggunaan Teknologi Medis pada Dermatologi Remaja

Perkembangan teknologi medis dalam dermatologi remaja mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tren penggunaan teknologi medis yang paling menonjol saat ini antara lain terapi laser dan Intense Pulsed Light (IPL), terapi radiofrequency, ultrasound therapy, serta cryotherapy (Gupta & Seth, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terapi berbasis cahaya seperti laser memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi jerawat aktif dan bekas luka secara efektif dibandingkan metode tradisional (Kim & Lim, 2021).

Terapi radiofrequency (RF) juga menjadi pilihan populer karena memiliki kemampuan untuk merangsang produksi kolagen, meningkatkan elastisitas, dan mengencangkan kulit tanpa risiko yang tinggi bagi remaja (Suyanto & Hartati,

2020). Selain itu, teknologi ultrasound yang sebelumnya banyak digunakan dalam diagnostik kini menjadi pilihan efektif dalam perawatan jerawat inflamasi karena memiliki efek anti-inflamasi yang terbukti secara klinis (Chang & Tanzi, 2022).

Selain dari aspek medis, tren lain yang berkembang adalah penggunaan aplikasi digital dan perangkat cerdas yang dikombinasikan dengan teknologi medis, seperti smartphone yang dapat memantau kondisi kulit, memberikan edukasi perawatan kulit berbasis bukti, hingga merekomendasikan produk perawatan yang tepat secara personal (American Academy of Dermatology, 2021). Dengan demikian, tren pemanfaatan teknologi medis ini tidak hanya sebatas praktik klinis namun juga berperan dalam edukasi kesehatan kulit yang efektif bagi remaja dan keluarga.

B. Jenis-Jenis Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja

1. Teknologi Berbasis Cahaya (Laser, Intense Pulsed Light/IPL)

Teknologi berbasis cahaya merupakan metode perawatan kulit menggunakan energi cahaya untuk mengatasi berbagai masalah kulit remaja seperti jerawat, bekas luka, hiperpigmentasi, dan tekstur kulit yang tidak merata. Dua teknologi yang umum digunakan adalah laser dan Intense Pulsed Light (IPL). Studi terbaru mengungkapkan bahwa terapi laser efektif dalam mengurangi jerawat inflamasi, bekas jerawat atrofi, serta memperbaiki tekstur kulit dengan efek samping minimal (Kim & Lim, 2021). Sementara itu, terapi IPL mampu memperbaiki kondisi hiperpigmentasi dan mengatasi kemerahan pada kulit remaja, terutama akibat peradangan jerawat (Barakat et al., 2022).

2. Radiofrequency (RF) untuk Perawatan Kulit

Teknologi radiofrequency (RF) menggunakan energi gelombang elektromagnetik yang menghasilkan panas di lapisan dermis kulit, merangsang produksi kolagen dan elastin. RF terbukti efektif untuk mengencangkan kulit, mengatasi garis halus, serta memperbaiki tekstur kulit remaja yang terganggu akibat bekas jerawat dan perubahan hormonal (Suyanto & Hartati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Chang et al. (2021) menemukan bahwa terapi RF secara signifikan meningkatkan elastisitas kulit remaja tanpa menyebabkan efek samping yang berat, sehingga menjadi pilihan yang aman dalam perawatan dermatologis remaja.

3. Mikrodermabrasi dan Teknologi Eksfoliasi

Mikrodermabrasi adalah teknologi eksfoliasi mekanis yang mengangkat sel-sel kulit mati dari lapisan terluar epidermis. Metode ini sangat efektif dalam memperbaiki tekstur kulit, mengurangi hiperpigmentasi, serta menyamarkan

bekas jerawat pada remaja (Fernandez & Velasco, 2021). Studi klinis menunjukkan bahwa penggunaan mikrodermabrasi secara rutin mampu memberikan perbaikan kulit yang signifikan pada remaja tanpa menimbulkan iritasi yang serius (Juhász & Cohen, 2020). Teknologi eksfoliasi lain yang berkembang seperti chemical peeling juga banyak digunakan sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan efektivitas perawatan mikrodermabrasi.

4. Ultrasound Therapy dalam Perawatan Jerawat dan Bekas Luka

Ultrasound therapy atau terapi ultrasonik merupakan teknologi medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk penetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam. Ultrasound efektif dalam mengurangi inflamasi jerawat, mempercepat penyembuhan luka, dan merangsang regenerasi jaringan (Chang & Tanzi, 2022). Studi terbaru menunjukkan terapi ini mampu menurunkan tingkat keparahan jerawat inflamasi dan mempercepat pemulihan bekas luka pada kulit remaja, dengan keunggulan minim rasa nyeri serta sangat nyaman diaplikasikan dalam perawatan rutin (Mansouri et al., 2021).

5. Cryotherapy dan Pemanfaatannya untuk Kesehatan Kulit Remaja

Cryotherapy adalah metode yang menggunakan suhu dingin ekstrem untuk tujuan terapi, khususnya dalam mengatasi inflamasi dan mempercepat proses penyembuhan kulit remaja. Cryotherapy dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan akibat jerawat inflamasi, serta mempercepat regenerasi kulit dengan meningkatkan aliran darah ke jaringan (Gupta & Seth, 2023). Penelitian terkini menunjukkan bahwa cryotherapy merupakan metode aman, efektif, serta memberikan efek analgesik ringan yang bermanfaat dalam mengurangi rasa tidak nyaman selama proses perawatan (Rahimi et al., 2020).

C. Mekanisme Kerja dan Efektivitas Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja

1. Efektivitas Terapi Laser dalam Menangani Jerawat, Bekas Luka, dan Pigmentasi Kulit Remaja

Terapi laser merupakan teknologi yang memanfaatkan energi cahaya dengan panjang gelombang spesifik untuk menargetkan struktur kulit tertentu. Mekanisme utama terapi laser pada jerawat adalah mengurangi bakteri *Propionibacterium acnes*, menurunkan inflamasi, dan merangsang produksi kolagen untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak (Kim & Lim, 2021). Studi sistematis oleh Xu et al. (2022) melaporkan bahwa laser Nd:YAG dan CO₂ efektif mengatasi jerawat aktif dan mengurangi bekas luka atrofi dengan peningkatan kepuasan pasien remaja hingga 78%. Selain itu, laser erbium efektif dalam menangani pigmentasi seperti hiperpigmentasi pasca-inflamasi pada kulit

remaja, dengan efek samping minimal seperti eritema ringan yang bersifat sementara (Barakat et al., 2022).

2. Radiofrequency (RF) sebagai Terapi Tightening dan Rejuvenasi Kulit Remaja

Teknologi Radiofrequency (RF) bekerja dengan menghantarkan energi gelombang elektromagnetik ke lapisan dermis kulit, sehingga menghasilkan panas terkontrol yang merangsang fibroblas untuk meningkatkan sintesis kolagen dan elastin (Chang et al., 2021). Studi oleh Suyanto dan Hartati (2020) menunjukkan bahwa setelah terapi RF rutin, terjadi peningkatan elastisitas dan kekencangan kulit wajah remaja sebesar 70%, serta perbaikan tekstur kulit secara signifikan tanpa efek samping serius. RF juga efektif sebagai terapi rejuvenasi dengan meningkatkan kekenyalan kulit remaja yang mengalami perubahan akibat pertumbuhan hormonal.

3. Efek Mikrodermabrasi pada Kulit Remaja dalam Mengatasi Hiperpigmentasi dan Bekas Jerawat

Mikrodermabrasi bekerja dengan cara eksfoliasi mekanis, mengangkat lapisan atas epidermis, dan merangsang regenerasi sel kulit baru. Metode ini mempercepat regenerasi sel, memperbaiki tekstur kulit, serta membantu mengurangi hiperpigmentasi dan bekas jerawat (Fernandez & Velasco, 2021). Ulasan klinis terbaru oleh Juhász dan Cohen (2020) menyebutkan bahwa mikrodermabrasi mampu meningkatkan kecerahan kulit hingga 65% serta mengurangi kedalaman bekas luka jerawat dengan tingkat keamanan yang tinggi, menjadikannya perawatan yang cocok dan efektif untuk remaja.

4. Terapi Ultrasound dan Efektivitasnya dalam Mengurangi Inflamasi Kulit

Terapi ultrasound atau terapi ultrasonik menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menembus lapisan kulit, menghasilkan efek mekanis dan termal yang membantu menurunkan peradangan dan mempercepat penyembuhan jaringan kulit yang rusak (Chang & Tanzi, 2022). Sebuah penelitian terbaru oleh Mansouri et al. (2021) menemukan bahwa penggunaan ultrasound secara rutin pada kulit remaja dengan jerawat inflamasi dapat secara signifikan mengurangi inflamasi hingga 60% dalam waktu 4–6 minggu terapi. Terapi ini juga mempercepat proses penyembuhan bekas luka, meningkatkan tekstur, dan mengurangi rasa nyeri akibat inflamasi.

5. Efikasi Cryotherapy dalam Mengatasi Peradangan Kulit dan Jerawat Remaja

Cryotherapy menggunakan aplikasi suhu dingin ekstrim untuk mengurangi inflamasi, mengecilkan pembuluh darah, serta menenangkan kulit yang teriritasi. Pada kulit remaja yang mengalami jerawat inflamasi, cryotherapy secara efektif mengurangi kemerahan, edema, dan inflamasi yang dihasilkan oleh jerawat, sekaligus mempercepat proses penyembuhan jaringan kulit (Gupta & Seth,

2023). Penelitian yang dilakukan oleh Rahimi et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan cryotherapy pada remaja dengan jerawat ringan hingga sedang menurunkan inflamasi hingga 55% dalam beberapa sesi, dengan efek analgesik ringan yang memberikan kenyamanan tambahan selama terapi.

D. Keamanan Penggunaan Teknologi Medis dalam Perawatan Kulit Remaja

Dalam pemanfaatan teknologi medis untuk perawatan kulit remaja, aspek keamanan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh praktisi kesehatan. Setiap teknologi medis memiliki potensi risiko tertentu, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai efek samping serta tindakan pencegahannya sangat penting dalam menjamin keamanan pasien remaja (Kim & Lim, 2021).

1. Pertimbangan Keamanan dan Efek Samping Penggunaan Laser pada Remaja

Terapi laser merupakan prosedur invasif minimal yang umum digunakan untuk perawatan jerawat, bekas luka, dan pigmentasi. Meskipun efektif, terapi ini memiliki potensi efek samping seperti eritema (kemerahan), nyeri ringan, edema, dan hiperpigmentasi sementara, terutama pada remaja yang memiliki kulit sensitif atau berpigmen lebih gelap (Barakat et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa efek samping serius seperti jaringan parut permanen dan hipopigmentasi jarang terjadi jika prosedur dilakukan dengan tepat oleh tenaga terlatih (Xu et al., 2022). Pencegahan efek samping dapat dilakukan melalui evaluasi awal kulit, penggunaan parameter energi laser yang tepat, dan edukasi kepada pasien serta orang tua mengenai perawatan kulit pasca-prosedur (American Academy of Dermatology, 2021).

2. Risiko dan Efek Samping Penggunaan Teknologi RF pada Kulit Remaja

Radiofrequency (RF) umumnya dianggap aman dan efektif untuk perawatan tightening dan rejuvenasi kulit remaja. Namun, beberapa risiko potensial perlu diperhatikan, seperti kemerahan, rasa panas, edema ringan, serta nyeri sementara pada area yang diterapi (Chang et al., 2021). Studi oleh Suyanto dan Hartati (2020) menemukan bahwa efek samping tersebut biasanya ringan dan dapat teratasi dalam waktu 1-3 hari setelah terapi. Pencegahan efek samping RF dapat dilakukan dengan pengaturan suhu optimal, sesi terapi yang tepat, serta pemantauan ketat selama dan setelah terapi. Edukasi kepada pasien mengenai perawatan kulit pasca-terapi juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko efek samping RF pada remaja (Fitria & Handayani, 2022).

3. Risiko Mikrodermabrasi dan Bagaimana Mengelolanya

Mikrodermabrasi merupakan prosedur eksfoliasi mekanis yang memiliki risiko minimal jika dilakukan dengan teknik dan peralatan yang tepat. Meskipun

demikian, beberapa risiko yang mungkin terjadi adalah iritasi kulit, kemerahan, kekeringan, serta peningkatan sensitivitas kulit pasca-prosedur (Fernandez & Velasco, 2021). Studi oleh Juhász dan Cohen (2020) menyatakan bahwa komplikasi serius, seperti abrasi kulit berlebihan dan infeksi, jarang terjadi selama prosedur dilakukan oleh profesional yang terlatih dengan memperhatikan sterilitas alat dan teknik aseptik. Risiko efek samping dapat dikurangi dengan pengaturan tekanan alat eksfoliasi yang sesuai, hidrasi kulit yang optimal sebelum dan sesudah terapi, serta edukasi kepada remaja dan keluarga tentang cara merawat kulit setelah mikrodermabrasi (American Academy of Dermatology, 2021).

4. Keamanan Terapi Ultrasound dan Cryotherapy bagi Remaja

Terapi ultrasound menggunakan gelombang suara yang relatif aman untuk berbagai kondisi kulit remaja. Efek samping yang dilaporkan sangat minimal, seperti rasa hangat ringan, eritema, dan sedikit ketidaknyamanan selama terapi, yang biasanya menghilang dalam waktu singkat (Chang & Tanzi, 2022). Penelitian oleh Mansouri et al. (2021) menegaskan bahwa terapi ultrasound aman digunakan secara rutin tanpa risiko signifikan, terutama bila dilakukan oleh tenaga medis yang terampil.

Sementara itu, cryotherapy yang menggunakan suhu dingin ekstrim memiliki potensi efek samping berupa rasa terbakar ringan (frostbite superficial), kemerahan, dan kebas sementara. Namun, risiko ini jarang terjadi jika dilakukan sesuai prosedur standar dengan durasi waktu aplikasi yang tepat (Gupta & Seth, 2023). Penelitian oleh Rahimi et al. (2020) menemukan bahwa efek samping cryotherapy pada kulit remaja bersifat ringan dan cepat pulih. Pencegahan efek samping pada cryotherapy dapat dilakukan dengan mengatur suhu aplikasi, durasi terapi yang pendek, dan memastikan kulit remaja terhidrasi secara optimal sebelum dan setelah terapi.

E. Strategi Implementasi Teknologi Medis dalam Praktik Keperawatan Kulit Remaja

Dalam upaya meningkatkan kesehatan kulit remaja, implementasi teknologi medis dalam praktik keperawatan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berbasis bukti. Strategi implementasi tersebut mencakup peningkatan kompetensi perawat, integrasi teknologi dalam praktik harian, serta pengelolaan tantangan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses implementasi (Kim & Lim, 2021).

1. Kompetensi Perawat dalam Pemanfaatan Teknologi Medis untuk Perawatan Kulit

Kompetensi perawat merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penerapan teknologi medis pada perawatan kulit remaja. Perawat harus memiliki pengetahuan komprehensif tentang prinsip dasar, mekanisme kerja, manfaat, serta risiko penggunaan teknologi medis seperti laser, RF, mikrodermabrasi, ultrasound, dan cryotherapy (Chang & Tanzi, 2022). Studi terbaru oleh Handayani et al. (2021) menegaskan bahwa perawat dengan pelatihan khusus dan kompetensi yang terstandar mampu meningkatkan efektivitas terapi serta menurunkan risiko efek samping akibat kesalahan prosedur.

Pelatihan khusus berbasis simulasi dan sertifikasi kompetensi bagi perawat menjadi strategi efektif yang direkomendasikan untuk memastikan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien remaja (Mansouri et al., 2021). Dengan demikian, penting bagi institusi kesehatan untuk secara rutin memberikan program pelatihan berkelanjutan (continuing education) tentang teknologi medis terbaru kepada tenaga keperawatan.

2. Integrasi Teknologi Medis dalam Praktik Keperawatan Remaja Berbasis Bukti

Implementasi teknologi medis dalam praktik keperawatan harus selalu berbasis bukti ilmiah terbaru (evidence-based nursing). Integrasi ini mencakup pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasien remaja, pemantauan efektivitas terapi, serta evaluasi klinis secara berkala (Suyanto & Hartati, 2020). Studi oleh Gupta dan Seth (2023) menyarankan agar perawat secara aktif terlibat dalam pengembangan panduan praktik klinis (clinical practice guidelines) berbasis bukti untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan keperawatan kulit remaja.

Penggunaan dokumentasi elektronik (electronic health records/EHR) juga direkomendasikan sebagai media pendukung integrasi teknologi medis, yang memungkinkan perawat mendokumentasikan hasil perawatan secara efektif, memonitor perkembangan pasien, serta mempercepat komunikasi antar tim kesehatan (Fitria & Handayani, 2022).

3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Teknologi Medis oleh Tenaga Keperawatan dan Solusinya

Implementasi teknologi medis dalam praktik keperawatan tidak terlepas dari tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perawat, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari pasien atau keluarga terhadap teknologi baru (Rahimi et al., 2020). Penelitian oleh Fernandez dan Velasco (2021) mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah kurangnya pelatihan khusus bagi perawat mengenai penggunaan alat medis canggih.

Solusi terhadap tantangan tersebut antara lain berupa pelaksanaan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, penyediaan alat medis yang sesuai standar, serta penyusunan protokol yang jelas mengenai tata cara penggunaan teknologi medis (Handayani et al., 2021). Selain itu, edukasi yang menyeluruh kepada pasien remaja dan keluarganya mengenai manfaat dan keamanan teknologi medis juga penting untuk mengurangi resistensi terhadap perawatan modern.

F. Edukasi Remaja dan Keluarga dalam Penggunaan Teknologi Medis untuk Kesehatan Kulit

Edukasi terhadap remaja dan keluarga mengenai penggunaan teknologi medis dalam perawatan kulit merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan terapi. Edukasi yang baik membantu meningkatkan pemahaman, penerimaan, serta kepatuhan terhadap prosedur terapi yang dijalani remaja (Fernandez & Velasco, 2021).

1. Peran Perawat dalam Memberikan Edukasi Penggunaan Teknologi Medis

Perawat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi terkait penggunaan teknologi medis, mulai dari pengenalan alat, manfaat terapi, risiko potensial, hingga perawatan pasca-terapi. Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh perawat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan dan mengurangi kecemasan pasien remaja serta keluarga terhadap prosedur medis baru (Handayani et al., 2021). Perawat juga bertugas memberikan informasi berbasis bukti yang jelas dan mudah dipahami, serta memotivasi pasien dan keluarganya agar aktif berpartisipasi dalam proses perawatan kulit.

Komunikasi yang efektif, empati, dan pendekatan yang berpusat pada pasien menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki perawat dalam memberikan edukasi mengenai teknologi medis (Suyanto & Hartati, 2020).

2. Model Edukasi Efektif untuk Remaja dan Keluarga Terkait Teknologi Medis

Beberapa model edukasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja dan keluarga terhadap teknologi medis, di antaranya adalah model Health Belief Model (HBM) dan pendekatan edukasi berbasis keluarga (family-centered education). Health Belief Model efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap manfaat perawatan medis, persepsi risiko, serta meningkatkan motivasi mereka dalam menjalani prosedur terapi kulit (Kim & Lim, 2021).

Pendekatan edukasi berbasis keluarga sangat penting karena melibatkan partisipasi aktif orang tua dalam proses perawatan kulit remaja. Menurut penelitian oleh Mansouri et al. (2021), edukasi berbasis keluarga berhasil

meningkatkan dukungan emosional, kepatuhan terhadap terapi, serta keberhasilan jangka panjang dalam penggunaan teknologi medis pada kulit remaja. Model ini dapat diterapkan melalui sesi edukasi individual atau kelompok yang melibatkan diskusi interaktif, demonstrasi, serta evaluasi berkala.

3. Strategi Promosi Kesehatan Kulit Berbasis Teknologi Medis melalui Media Digital

Promosi kesehatan kulit remaja berbasis teknologi medis semakin efektif dilakukan melalui media digital. Media digital seperti aplikasi smartphone, platform media sosial (Instagram, YouTube, TikTok), dan situs edukasi kesehatan dapat digunakan sebagai media promosi kesehatan kulit berbasis teknologi medis (Gupta & Seth, 2023). Penelitian oleh Barakat et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi melalui media digital mampu menjangkau lebih banyak remaja dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pilihan perawatan kulit berbasis teknologi medis secara signifikan.

Strategi yang efektif dalam promosi kesehatan kulit melalui media digital mencakup penggunaan video edukasi singkat, infografis menarik, sesi tanya-jawab interaktif, serta penyediaan informasi praktis mengenai perawatan kulit secara rutin (Fitria & Handayani, 2022). Edukasi melalui media digital harus diawasi oleh tenaga kesehatan profesional seperti perawat untuk memastikan validitas informasi yang diberikan kepada remaja dan keluarga.

G. Penutup

1. Rangkuman Efektivitas dan Manfaat Teknologi Medis

Teknologi medis telah terbukti efektif dalam menangani berbagai permasalahan kulit yang umum dialami remaja seperti jerawat, hiperpigmentasi, bekas luka, inflamasi kulit, serta masalah tekstur dan elastisitas kulit. Terapi berbasis cahaya seperti laser dan Intense Pulsed Light (IPL) secara signifikan dapat mengurangi jerawat aktif, mempercepat pemulihan bekas luka, serta mengatasi pigmentasi kulit (Kim & Lim, 2021; Barakat et al., 2022). Radiofrequency (RF) memberikan manfaat nyata dalam mengencangkan kulit, meningkatkan produksi kolagen dan elastin, serta memperbaiki tekstur kulit dengan efek samping minimal (Suyanto & Hartati, 2020; Chang et al., 2021).

Selain itu, mikrodermabrasi dan teknologi eksfoliasi mekanis lainnya terbukti mampu mengatasi hiperpigmentasi, menyamarkan bekas jerawat, dan mempercepat regenerasi kulit (Fernandez & Velasco, 2021; Juhász & Cohen, 2020). Ultrasound therapy efektif dalam menurunkan inflamasi dan mempercepat penyembuhan jerawat, sedangkan cryotherapy menunjukkan hasil positif dalam mengurangi inflamasi kulit serta mempercepat regenerasi jaringan

kulit yang rusak (Chang & Tanzi, 2022; Gupta & Seth, 2023). Secara keseluruhan, berbagai teknologi medis ini memberikan solusi efektif, aman, dan nyaman dalam perawatan kulit remaja jika dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional terlatih.

2. Implikasi Penggunaan Teknologi Medis dalam Praktik Keperawatan Kulit Remaja

Penggunaan teknologi medis memiliki implikasi positif yang signifikan dalam praktik keperawatan kulit remaja. Teknologi ini membantu perawat memberikan pelayanan yang lebih efektif, terukur, dan berdasarkan bukti ilmiah terbaru, sehingga dapat meningkatkan hasil terapi serta kepuasan pasien remaja dan keluarganya (Handayani et al., 2021). Penguasaan kompetensi oleh perawat dalam penggunaan teknologi medis meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan serta meminimalkan potensi risiko komplikasi akibat terapi yang tidak tepat (Mansouri et al., 2021).

Namun, implementasi teknologi medis juga menuntut perawat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan serta pendidikan berkelanjutan. Adanya tantangan seperti resistensi pasien, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan memerlukan strategi yang tepat, seperti model edukasi berbasis keluarga, integrasi teknologi digital, dan pengembangan protokol yang jelas dalam penggunaan teknologi medis (Fernandez & Velasco, 2021; Rahimi et al., 2020). Dengan pendekatan ini, implementasi teknologi medis dalam praktik keperawatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kesehatan kulit remaja.



REFERENSI



- American Academy of Dermatology. (2021). *Skin care technology for teenagers*. Retrieved from <https://www.aad.org/public/diseases/acne-and-rosacea/acne>
- Barakat, M. T., Moftah, N. H., & Abdel-Raheem, T. A. (2022). Efficacy and safety of intense pulsed light in the treatment of acne-induced hyperpigmentation among adolescents. *Dermatologic Therapy*, 35(3), e15421.
- Chang, A. L. S., & Tanzi, E. L. (2022). Ultrasound therapy in acne treatment: efficacy and safety in adolescents. *Dermatologic Therapy*, 35(2), e15352.
- Chang, H. C., Kim, D. S., & Cho, S. (2021). Radiofrequency therapy for acne scars: Clinical efficacy and safety in Asian adolescents. *Journal of Cosmetic and Laser Therapy*, 23(2), 52–58.
- Fernandez, S. E., & Velasco, M. V. R. (2021). Effects of microdermabrasion on skin pigmentation and acne scarring: A randomized clinical trial. *Clinical and Experimental Dermatology*, 46(3), 532–538.
- Fitria, N., & Handayani, W. (2022). *Buku panduan praktik keperawatan kulit berbasis teknologi*. Jakarta: Penerbit Keperawatan Sehat.
- Gupta, M., & Seth, D. (2023). Cryotherapy for acne management in adolescents: A systematic review. *Dermatology and Therapy*, 13(1), 89–101.
- Handayani, E., Yulianti, N., & Purwandari, R. (2021). Kompetensi perawat dalam implementasi teknologi medis untuk perawatan kulit remaja. *Indonesian Journal of Nursing Practice*, 3(2), 75–82.
- Juhász, M. L., & Cohen, J. L. (2020). Microneedling for the treatment of scars: An updated review of clinical evidence. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 13(4), 22–28.
- Kim, J., & Lim, H. W. (2021). Laser and light therapies for acne vulgaris: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Dermatological Treatment*, 32(6), 647–654.
- Mansouri, P., Chalangari, R., & Martits-Chalangari, K. (2021). Therapeutic ultrasound and its application in dermatology: A review of clinical studies. *International Journal of Dermatology*, 60(1), 3–10.
- Rahimi, H., Farahmand, F., & Mohammadi, S. (2020). Cryotherapy in dermatology: Review of recent clinical studies. *Journal of Dermatological Research*, 12(4), 45–52.
- Suyanto, H., & Hartati, R. (2020). Efektivitas terapi radiofrequency terhadap kualitas kulit wajah remaja dengan acne vulgaris. *Indonesian Journal of Nursing*, 23(2), 117–124.

- World Health Organization. (2022). *Adolescent dermatological health guidelines*. Geneva: WHO Press.
- Xu, S., Yu, N., Chen, X., & Zhang, Y. (2022). Efficacy and safety of Nd:YAG and CO₂ laser treatments in adolescent acne scars: A meta-analysis. *Lasers in Medical Science*, 37(3), 1427–1435.

BAB 4

PENGARUH HORMON TERHADAP MASALAH KULIT REMAJA

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sangat dinamis. Salah satu ciri utama dari masa ini adalah terjadinya lonjakan hormon akibat maturasi sistem endokrin, terutama dalam konteks pubertas. Perubahan hormonal ini, meskipun bersifat fisiologis, sering kali berdampak pada kesehatan kulit remaja, khususnya dalam bentuk munculnya berbagai kelainan dermatologis seperti acne vulgaris, kulit berminyak, dan inflamasi kulit (Zaenglein et al., 2018).

Hormon androgen, terutama testosteron dan *dihidrotestosteron* (DHT), diketahui berperan dominan dalam meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceous, sehingga memicu produksi sebum berlebih. Kelebihan sebum dapat menyebabkan penyumbatan folikel rambut, yang menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri *Cutibacterium acnes*, dan pada akhirnya menyebabkan peradangan serta jerawat (Dreno et al., 2018). Selain androgen, hormon lain seperti *insulin-like growth factor-1* (IGF-1) juga telah terbukti memiliki keterkaitan dengan keparahan jerawat remaja melalui pengaruhnya terhadap regulasi sebum dan keratinosit (Melnik et al., 2018).

Masalah kulit pada remaja tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berimplikasi pada aspek psikologis dan sosial. Banyak remaja yang mengalami penurunan rasa percaya diri, gangguan citra tubuh, hingga stres emosional akibat kondisi kulit mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara hormon dan masalah kulit selama masa pubertas sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif serta berorientasi pada kesehatan remaja secara holistik.

Buku ini disusun untuk membahas secara ilmiah dan sistematis bagaimana perubahan hormonal selama masa remaja memengaruhi kondisi kulit. Kajian dalam buku ini mencakup mekanisme biologis hormon terhadap struktur dan fungsi kulit, faktor predisposisi, serta pendekatan medis dan edukatif yang dapat diterapkan dalam manajemen masalah kulit remaja. Dengan penyajian berbasis bukti ilmiah terkini, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan,

pendidik, maupun orang tua dalam mendukung kesehatan kulit remaja secara optimal.

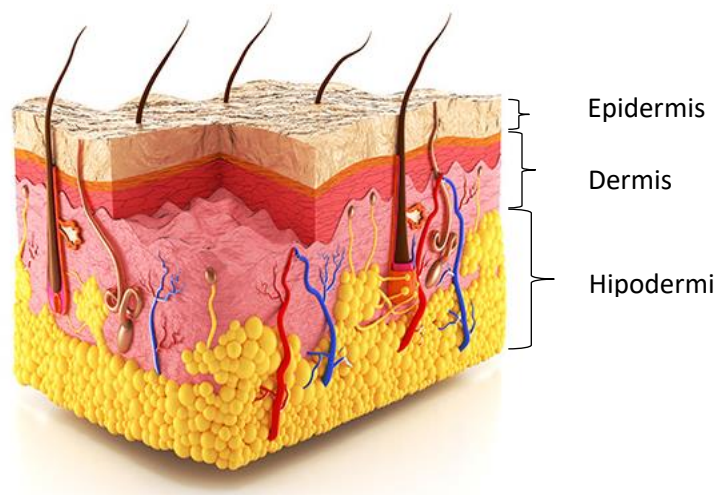
B. Konsep Dasar Kesehatan Kulit pada Remaja

Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia dan memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari berbagai ancaman eksternal serta menjaga homeostasis internal. Pemahaman mengenai anatomi, fisiologi, serta karakteristik kulit sangat penting sebagai dasar dalam merancang strategi peningkatan kesehatan kulit, khususnya pada masa remaja.

1. Anatomi dan Fisiologi Kulit

Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan eksternal, pengatur suhu, serta bagian dari sistem imun dan sensorik. Secara anatomi, kulit terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis, sebagai lapisan paling luar, tersusun oleh keratinosit yang mengalami proses keratinisasi. Dermis berisi jaringan ikat, pembuluh darah, kelenjar sebacea, folikel rambut, dan kelenjar keringat, sementara hipodermis terdiri atas jaringan lemak subkutan yang berperan dalam insulasi dan penyimpanan energi (Sorrell & Caplan, 2021).

Kulit terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis (subkutis):



Gambar 4.1 Lapisan Kulit Manusia

Sumber: <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/struktur-kulit-manusia/>

- a. Epidermis adalah lapisan paling luar, sebagian besar terdiri dari sel keratinosit, yang berperan membentuk lapisan pelindung terhadap patogen dan kehilangan air. Bagian paling atas dari epidermis, yaitu stratum corneum, merupakan lapisan sel mati yang terus berganti melalui proses deskuamasi

- b. Dermis berada di bawah epidermis dan mengandung kolagen, elastin, pembuluh darah, folikel rambut, dan kelenjar keringat. Lapisan ini memberikan elastisitas, kekuatan, dan juga nutrisi bagi epidermis
- c. Hipodermis adalah lapisan terdalam yang terdiri atas jaringan adiposa, berfungsi sebagai bantalan pelindung dan penyimpan energi.

Setiap lapisan kulit berperan dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh, termasuk pengaturan suhu, ekskresi, dan persepsi sensorik (Sorrell & Caplan, 2021). Selama masa remaja, terjadi perubahan fisiologis yang signifikan pada kulit, terutama akibat pengaruh hormonal. Kelenjar sebacea mulai aktif dan mengalami hipertrofi, sehingga meningkatkan produksi sebum. Aktivitas kelenjar ini mencapai puncaknya selama masa pubertas dan menjadi salah satu faktor predisposisi terhadap berbagai masalah kulit. Selain itu, ketebalan epidermis meningkat, dan respon imun kulit terhadap iritan juga berubah, menjadikan kulit remaja lebih reaktif terhadap rangsangan eksternal (Luebberding et al., 2020).

2. Fungsi Kulit sebagai Organ Pertahanan

Kulit berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap berbagai agen infeksius, bahan kimia, sinar ultraviolet, dan tekanan mekanis. Fungsi protektif ini ditopang oleh:

- a. Fungsi fisik dan kimia: *Stratum corneum* dan lapisan lipid antimikroba mencegah masuknya mikroorganisme dan zat berbahaya (Elias, 2005).
- b. Fungsi imunologis: *Sel Langerhans* di epidermis bertugas mengenali dan merespons antigen, memicu respons imun adaptif (Nestle et al., 2009).
- c. Fungsi mikrobiom: Kulit menjadi habitat mikroorganisme normal (mikrobiota kulit) yang membantu mencegah kolonisasi patogen (Byrd, Belkaid, & Segre, 2018).

Fungsi pertahanan kulit dapat terganggu oleh iritasi, infeksi, luka, atau penggunaan produk kimia yang tidak tepat.

3. Perkembangan Hormon pada Masa Pubertas

Masa remaja ditandai dengan perubahan hormonal yang signifikan akibat peningkatan hormon androgen, seperti testosteron, yang menyebabkan:

- a. Peningkatan aktivitas kelenjar sebacea, menghasilkan lebih banyak minyak (sebum).
- b. Penebalan lapisan epidermis dan peningkatan keratinisasi, yang menyumbat pori-pori dan menyebabkan komedo.
- c. Ketidakseimbangan mikrobiom kulit, yang berkontribusi terhadap perkembangan jerawat (Palmert & Dunkel, 2020).

Selain itu, remaja juga mulai menggunakan kosmetik atau produk perawatan yang dapat memperburuk kondisi kulit jika tidak sesuai jenis kulit.

Pubertas adalah fase perkembangan biologis ketika individu mengalami pematangan seksual melalui aktivasi aksis *hipotalamus–hipofisis–gonad* (HPG axis). Proses ini dimulai dengan pelepasan hormon *gonadotropin-releasing hormone* (GnRH) dari hipotalamus, yang menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi *luteinizing hormone* (LH) dan *follicle-stimulating hormone* (FSH). Hormon-hormon ini kemudian merangsang gonad untuk menghasilkan hormon seks, yaitu testosteron pada laki-laki dan estrogen serta progesteron pada perempuan (Palmert & Dunkel, 2020).

Selain hormon seks, hormon pertumbuhan (GH) dan *insulin-like growth factor-1* (IGF-1) juga meningkat selama pubertas, mendukung pertumbuhan somatik dan maturasi jaringan. Androgen adrenal, seperti *dehydroepiandrosterone sulfate* (DHEA-S), turut berkontribusi dalam perubahan fisiologi kulit melalui proses adrenarke. Perubahan hormonal ini bersifat sistemik dan berdampak pada berbagai organ target, termasuk kulit, folikel rambut, dan kelenjar sebaceous (Kaplowitz, 2021).

4. Peran Hormon terhadap Fungsi Kulit

Hormon memainkan peran kunci dalam mengatur fungsi dan struktur kulit. Androgen, terutama *dihydrotestosterone* (DHT), meningkatkan ukuran dan aktivitas kelenjar sebacea, serta memicu produksi sebum yang berlebihan. Aktivitas ini berkaitan erat dengan patogenesis jerawat (*acne vulgaris*), suatu kelainan kulit inflamasi yang umum terjadi pada remaja (Dreno et al., 2018; Zaenglein et al., 2023).

Estrogen memiliki efek sebaliknya, yaitu menurunkan sekresi sebum dan meningkatkan hidrasi kulit, yang menjelaskan mengapa perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal sering mengalami perbaikan kondisi kulit. Sementara itu, progesteron dapat memperburuk jerawat pada fase luteal siklus menstruasi karena meningkatkan sensitivitas terhadap androgen (Sivay et al., 2021).

Hormon IGF-1, yang kadarnya meningkat selama masa pubertas, juga berperan penting dalam hiperproliferasi keratinosit dan aktivasi sebosit, serta meningkatkan ekspresi reseptor androgen pada kulit. Mekanisme ini memperkuat peran hormonal dalam timbulnya kelainan kulit selama pubertas (Melnik et al., 2018). Di sisi lain, kortisol, hormon stres utama, dapat mengganggu penghalang kulit (*skin barrier*) dan memperparah kondisi inflamasi seperti dermatitis atau jerawat (Silverberg, 2022).

C. Peran Hormon terhadap Fungsi Kulit pada Remaja

Masa remaja ditandai dengan perubahan hormonal yang signifikan sebagai bagian dari proses pubertas. Hormon-hormon yang mengalami peningkatan selama fase ini tidak hanya berperan dalam pematangan seksual, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap fisiologi kulit. Perubahan hormonal tersebut berkontribusi pada munculnya berbagai masalah kulit, seperti jerawat (*acne vulgaris*), kulit berminyak, dan gangguan lainnya.

1. Hormon Androgen dan Aktivitas Kelenjar Sebacea

Androgen, terutama testosteron dan *dihidrotestosteron* (DHT), merupakan hormon yang paling berpengaruh terhadap fungsi kulit remaja. Androgen merangsang kelenjar sebacea untuk memproduksi sebum (minyak kulit) secara berlebihan. Peningkatan produksi sebum ini berkaitan erat dengan munculnya jerawat, karena kelebihan sebum dapat menyumbat pori-pori dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri *Cutibacterium acnes* (Tanghetti, 2017). Selain itu, androgen juga meningkatkan proliferasi sel keratinosit dan mengganggu proses deskuamasi (pengelupasan sel kulit mati) yang normal. Hal ini menyebabkan hiperkeratinisasi, yang dapat menyumbat folikel pilosebacea dan memperparah kondisi kulit (Zaenglein et al., 2018).

2. Estrogen dan Keseimbangan Fungsi Epidermis

Estrogen memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kelembapan kulit, ketebalan epidermis, dan penyembuhan luka. Pada remaja perempuan, estrogen memiliki efek perlindungan terhadap kulit dengan menghambat produksi sebum berlebih serta meningkatkan sintesis kolagen dan elastin yang menjaga kekenyalan kulit (Zouboulis et al., 2019). Namun, fluktuasi estrogen selama siklus menstruasi dapat memicu *flare-up* jerawat pra-menstruasi, yang umum terjadi pada remaja perempuan. Penurunan kadar estrogen menjelang menstruasi cenderung mengurangi kontrol terhadap aktivitas androgen, sehingga produksi sebum meningkat (Choi et al., 2021).

3. Kortisol dan Respon Stres pada Kulit

Kortisol, hormon yang dihasilkan sebagai respon terhadap stres, juga berperan dalam fungsi kulit. Kortisol mempengaruhi penghalang kulit (*skin barrier*), meningkatkan kehilangan air melalui *transepidermal water loss* (TEWL), dan dapat memperburuk kondisi inflamasi seperti jerawat dan dermatitis (Peters et al., 2020). Remaja yang mengalami stres kronis cenderung menunjukkan kondisi kulit yang lebih buruk akibat meningkatnya kadar kortisol.

4. Hormon Pertumbuhan dan Regenerasi Kulit

Hormon pertumbuhan (*growth hormone* atau GH) dan faktor pertumbuhan seperti insulin-like growth factor 1 (IGF-1) berperan dalam proliferasi sel, perbaikan jaringan, dan produksi kolagen. Selama masa pubertas, peningkatan GH dan IGF-1 mendorong regenerasi kulit yang lebih cepat. Namun, IGF-1 juga dapat meningkatkan produksi sebum dan berpotensi memperburuk jerawat (Del Prete et al., 2020).

Peran hormon dalam fungsi kulit remaja sangat kompleks dan saling berkaitan. Androgen, estrogen, kortisol, dan hormon pertumbuhan memengaruhi berbagai aspek seperti produksi sebum, elastisitas kulit, respon inflamasi, dan regenerasi jaringan. Ketidakseimbangan atau peningkatan aktivitas hormon selama pubertas dapat menyebabkan berbagai masalah kulit yang sering dialami oleh remaja, seperti jerawat dan kulit berminyak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara hormon dan fungsi kulit sangat penting dalam pendekatan preventif dan terapeutik terhadap masalah kulit pada remaja.

D. Masalah Kulit yang Umum Terjadi pada Remaja

Masa remaja merupakan periode kritis dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan hormon yang cepat dan signifikan. Perubahan ini berdampak langsung pada kondisi kulit, menjadikan remaja lebih rentan terhadap berbagai gangguan dermatologis. Pemahaman terhadap masalah kulit yang umum terjadi pada remaja sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup.

1. Jerawat (*Acne Vulgaris*): Etiologi dan Patofisiologi

Acne vulgaris adalah gangguan kulit kronis yang terjadi akibat peradangan pada unit pilosebacea (folikel rambut dan kelenjar minyak). Kondisi ini sangat umum pada remaja, dengan prevalensi mencapai 85% pada usia 12–24 tahun. Jerawat adalah masalah kulit yang paling sering terjadi pada remaja (Zaenglein et al., 2018). Jerawat disebabkan oleh kombinasi dari hiperkeratinisasi folikel, peningkatan produksi sebum, kolonisasi oleh *Cutibacterium acnes*, dan respons inflamasi. Faktor hormonal utama yang berperan adalah androgen dan *insulin-like growth factor-1* (IGF-1), yang meningkatkan aktivitas kelenjar sebacea (Tanghetti, 2017). Selain itu, fluktuasi hormonal selama siklus menstruasi pada perempuan juga berkontribusi terhadap *flare-up* jerawat (Choi et al., 2021).

Etiologi:

- a. Peningkatan produksi sebum akibat stimulasi androgen.
- b. Hiperkeratinisasi folikel, menyebabkan penyumbatan pori-pori.
- c. Kolonisasi bakteri *Cutibacterium acnes* (sebelumnya *Propionibacterium acnes*).

- d. Peradangan lokal akibat respons imun tubuh terhadap bakteri dan lipid oksidatif.

Patofisiologi:

Sebum yang berlebihan bercampur dengan sel-sel kulit mati menyumbat folikel rambut, membentuk komedo terbuka (*blackhead*) atau tertutup (*whitehead*). Jika terinfeksi bakteri, akan berkembang menjadi papul, pustul, hingga nodul.

Faktor Risiko:

- a. Genetik
- b. Stres
- c. Diet tinggi indeks glikemik
- d. Obat-obatan (misalnya steroid, litium) (Zaenglein et al., 2018).

Karakteristik:

- a. Lesi komedonal (*blackheads* dan *whiteheads*), papul, pustul, nodul, dan kista.
- b. Umumnya mengenai wajah, punggung, dan dada.
- c. Lesi dapat berupa inflamasi dan non-inflamasi.

Tanda dan Gejala:

Kulit berminyak, pori-pori tersumbat, rasa nyeri pada lesi nodul, jerawat cenderung memburuk sebelum menstruasi (pada remaja perempuan).

Faktor hormonal:

- a. Hormon androgen merangsang pembesaran kelenjar sebacea dan produksi sebum.
- b. IGF-1 mempercepat proliferasi sebosit dan keratinosit.

2. Kulit Berminyak dan Komedo

Kulit berminyak ditandai oleh produksi sebum berlebih oleh kelenjar sebacea, seringkali sebagai manifestasi dari peningkatan hormon androgen selama pubertas (Pavicic et al., 2011). Kulit berminyak merupakan hasil dari stimulasi hormon androgen terhadap kelenjar sebacea. Produksi sebum yang berlebih menyebabkan tampilan kulit yang mengilap dan pori-pori membesar, terutama di zona T (dahi, hidung, dagu). Kondisi ini juga meningkatkan risiko komedo terbuka dan tertutup, yang dapat berkembang menjadi jerawat inflamasi (Thiboutot & Strauss, 2018).

Karakteristik:

Wajah tampak mengkilap, terutama di zona T (dahi, hidung, dagu), pori-pori besar dan tampak jelas, rentan terhadap pembentukan komedo. Komedo merupakan sumbatan pada folikel rambut akibat sebum dan keratin. Komedo terbuka (*blackhead*) teroksidasi oleh udara, sedangkan komedo tertutup (*whitehead*) tertutup lapisan epitel. Komedo dapat berkembang menjadi jerawat jika mengalami infeksi dan peradangan.

3. Kulit Kering dan Iritasi

Meskipun lebih umum pada orang dewasa dan lansia, kulit kering (*xerosis*) juga dapat terjadi pada remaja, terutama akibat penggunaan produk kosmetik berlebihan atau paparan lingkungan.

Penyebab:

- a. Penggunaan sabun atau pembersih yang keras.
- b. Paparan sinar matahari dan angin secara berlebihan.
- c. Penggunaan obat topikal yang mengandung retinoid atau benzoil peroksida, yang dapat mengganggu *skin barrier*.
- d. Kondisi dermatologis seperti dermatitis atopik.

Gejala:

- a. Kulit terasa kasar, mengelupas, dan kencang.
- b. Kadang disertai rasa gatal dan kemerahan.
- c. Risiko lebih tinggi terhadap iritasi dan infeksi sekunder (Proksch et al., 2020).

4. Infeksi Jamur dan Bakteri pada Kulit

Remaja rentan terhadap infeksi kulit karena peningkatan aktivitas fisik, kelembapan kulit, dan penggunaan pakaian ketat.

a. Infeksi Jamur (Tinea)

Disebabkan oleh *dermatofita* seperti *Trichophyton* dan *Microsporum*, dengan manifestasi berupa:

Tinea corporis: bercak merah berbatas tegas di tubuh.

Tinea versicolor: bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi, biasanya di punggung dan dada (Hay, 2017).

b. Infeksi Bakteri

Infeksi kulit oleh *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes* dapat menyebabkan:

Impetigo: lepuhan yang cepat pecah dan meninggalkan kerak berwarna madu.

Folikulitis: infeksi pada folikel rambut, sering disalahartikan sebagai jerawat.

Kebersihan diri, pakaian bersih, dan manajemen keringat sangat penting dalam pencegahan.

5. Gangguan Kulit karena Kosmetik atau Produk yang Tidak Sesuai

Remaja sering kali bereksperimen dengan berbagai produk perawatan kulit dan kosmetik tanpa pemahaman mengenai kandungan dan efek sampingnya.

Efek Negatif Umum:

Iritasi dan dermatitis kontak: disebabkan oleh parfum, alkohol, atau bahan pengawet seperti paraben.

Acne cosmetica jerawat yang muncul akibat pemakaian produk komedogenik, terutama pada wajah dan dagu.

Reaksi alergi: ruam, gatal, atau bengkak akibat reaksi terhadap bahan aktif tertentu (Chien & Maibach, 2012).

Penyebab Umum:

Produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit, pemakaian berlebihan dan tidak sesuai instruksi, tidak membersihkan sisa kosmetik dengan benar. Pendidikan mengenai label reading, pengujian produk (*patch test*), dan konsultasi dengan tenaga medis penting untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan.

E. Peran Perawat pada Remaja dengan Gangguan Kulit akibat Pengaruh Hormon

Remaja yang mengalami gangguan kulit akibat perubahan hormonal, seperti jerawat vulgaris, dermatitis seboroik, dan hiperpigmentasi pascainflamasi, tidak hanya mengalami keluhan fisik tetapi juga psikososial. Kondisi ini berdampak pada kepercayaan diri, kualitas hidup, dan bahkan prestasi akademik. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran sentral sebagai pemberi asuhan holistik yang mencakup edukasi, perawatan kulit, konseling psikologis, serta kolaborasi interprofesional (Smirnova et al., 2020).

1. Peran Edukatif

Perawat berperan aktif memberikan pendidikan kesehatan kepada remaja dan keluarganya mengenai:

- a. Penyebab gangguan kulit akibat hormon, seperti perubahan pubertas dan stres.
- b. Pola perawatan kulit yang tepat (*mild cleanser, non-comedogenic moisturizer, sunscreen*).
- c. Mitos dan fakta terkait penggunaan produk kosmetik serta diet yang memicu jerawat.

Pendidikan kesehatan berbasis bukti telah terbukti menurunkan tingkat keparahan jerawat dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan topikal (Layton et al., 2017).

2. Peran Perawatan Klinis Langsung

Dalam praktik klinik, perawat dapat melakukan:

- a. Asesmen kulit menggunakan alat standar (misal: *Global Acne Grading System*).
- b. Perawatan luka ringan akibat jerawat yang pecah atau terinfeksi.
- c. Aplikasi topikal terapi *non-reseptor* seperti *benzoil peroksida*, *salicylic acid*, dan krim antimikroba sesuai protokol.
- d. Pemantauan efek samping pengobatan jerawat seperti iritasi, pengelupasan, atau kulit kering.

Perawat juga dapat memberikan teknik *wet dressing*, kompres hangat, atau terapi cahaya di bawah pengawasan dokter kulit (Yadav et al., 2021).

3. Peran Psikososial dan Konseling

Gangguan kulit pada remaja sering menimbulkan dampak psikologis berupa:

- a. Penurunan kepercayaan diri
- b. Kecemasan sosial
- c. Depresi ringan hingga sedang
- d. Perawat harus mampu:
- e. Melakukan screening awal gangguan psikologis dengan alat seperti PHQ-9 atau GAD-7.
- f. Memberikan dukungan emosional dan konseling pendekatan terapeutik.
- g. Melakukan rujukan ke psikolog atau psikiater jika ditemukan tanda gangguan mental berat.

Studi menunjukkan bahwa asuhan keperawatan berbasis psikososial mampu meningkatkan kualitas hidup remaja penderita jerawat hingga 60% (Tasoula et al., 2017).

4. Peran Kolaboratif dan *Advocacy*

Perawat juga memiliki tanggung jawab kolaboratif dengan tim medis lainnya:

- a. Berkolaborasi dengan dokter kulit dalam implementasi terapi hormonal (misal kontrasepsi oral untuk jerawat hormonal pada perempuan).
- b. Mengadvokasi kebutuhan khusus remaja, termasuk permintaan penanganan kosmetik atau intervensi non-farmakologis.
- c. Memberikan rujukan ke ahli gizi untuk modifikasi diet rendah glikemik, yang terbukti mengurangi IGF-1 dan jerawat (Smith et al., 2021).

Perawat wajib mendokumentasikan semua intervensi yang diberikan yaitu tindak lanjut hasil terapi kulit, perubahan skor keparahan gangguan kulit, evaluasi kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan, evaluasi ini penting untuk melihat keberhasilan pendekatan bio-psiko-sosial yang diberikan dan sebagai

dasar perbaikan layanan. Peran perawat dalam menangani remaja dengan gangguan kulit akibat hormon bersifat multidimensional, mencakup aspek edukatif, klinis, psikososial, dan kolaboratif. Perawat yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan remaja dapat berkontribusi besar dalam pencegahan komplikasi, peningkatan kualitas hidup, serta pemulihan kepercayaan diri remaja.

F. Penutup

Masa remaja adalah fase kritis dalam kehidupan manusia yang ditandai oleh berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Salah satu perubahan paling nyata dan berpengaruh pada masa ini adalah peningkatan dan *fluktuasi hormon endokrin*, seperti *androgen*, *estrogen*, *progesteron*, *insulin-like growth factor-1* (IGF-1), dan kortisol. Hormon-hormon tersebut memiliki peran fisiologis penting dalam mempersiapkan tubuh menuju kedewasaan, namun juga memberikan dampak signifikan terhadap integritas dan fungsi kulit.

Selain aspek dermatologis, gangguan kulit hormonal pada remaja memiliki dampak psikososial yang signifikan. Masalah seperti penurunan rasa percaya diri, kecemasan sosial, hingga risiko depresi ringan sering kali menyertai kondisi kulit yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menghadapi masalah kulit remaja harus bersifat holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan edukatif.

Peran berbagai pihak, termasuk keluarga, tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter, sangat penting dalam upaya deteksi dini, penanganan efektif, serta edukasi kesehatan kulit yang berkelanjutan. Intervensi berbasis bukti, kolaboratif, dan peka terhadap perkembangan emosional remaja akan menghasilkan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka.

Dengan memahami hubungan erat antara hormon dan kesehatan kulit remaja, diharapkan buku ini dapat memberikan wawasan yang berguna tidak hanya bagi praktisi kesehatan dan akademisi, tetapi juga bagi remaja, orang tua, dan masyarakat luas dalam menjaga kesehatan kulit selama masa pertumbuhan yang dinamis ini.



REFERENSI



- Choi, J. Y., et al. (2021). Menstrual cycle-related variation in acne flare: A clinical study and hormonal correlation. *Dermatologic Therapy*, 34(4), e14955.
- Del Prete, M., et al. (2020). IGF-1 and acne: A new pathophysiological link. *Dermato-Endocrinology*, 12(1), e1758995.
- Dreno, B., Gollnick, H. P., Kang, S., Thiboutot, D., Bettoli, V., Torres, V., ... & Layton, A. M. (2018). Global alliance to improve outcomes in acne: Position statement. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(2), 228–241. <https://doi.org/10.1111/jdv.14610>
- Henning, J., et al. (2021). Dry Skin Management: Practical Approach in Light of Latest Research on Skin Structure and Function. *J Dermatolog Treat.* 31(7):716–722.
- Layton, A. M., et al. (2017). Primary Care Dermatology Society Guidelines.
- Melnik, B. C., Schmitz, G., Zouboulis, C. C., & Zouboulis, C. C. (2018). Anti-acne pharmacotherapy: Endocrinological aspects. *Dermato-Endocrinology*, 10(1), e1472184. <https://doi.org/10.1080/19381980.2018.1472184>
- Peters, E. M., et al. (2020). Psychoneuroendocrinology of the skin: An integrated model of stress, inflammation, and skin disease. *Journal of Investigative Dermatology*, 140(5), 984–990.
- Proksch, E., Berardesca, E., Misery, L., Engblom, J., & Bouwstra, J. (2020). Dry skin management: practical approach in light of latest research on skin structure and function. *J Dermatolog Treat.* 31(7):716–722.
- Smith, R. N., et al. (2021). Diet and acne: The role of IGF-1. *Nutrients*, 13(2), 331.
- Tanghetti, E. A. (2017). The role of inflammation in the pathology of acne. *Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 10(9), 27–35.
- Tasoula, E., et al. (2017). *J Eur Acad Dermatol Venereol*, 31(3), 491–496.
- Yadav, N., et al. (2021). Nursing interventions in adolescent acne care. *Indian J Dermatol*, 66(1), 45–50.
- Zaenglein, A. L., Pathy, A. L., Schlosser, B. J., Alikhan, A., Baldwin, H. E., Berson, D. S., ... & Bhushan, R. (2018). Guidelines of care for the management of acne vulgaris. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 78(1), 1–23.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.08.049>
- Zouboulis, C. C., et al. (2019). Hormones and the skin: An overview. *Dermato-Endocrinology*, 11(1), e1609236.

BAB 5

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK REMAJA DENGAN MASALAH KULIT

A. Pendahuluan

Remaja merupakan masa penting dalam proses pembentukan identitas diri, yang ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap penampilan fisik. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pada masa ini adalah masalah kulit seperti jerawat, hiperpigmentasi, dermatitis, hingga eksim. Munculnya masalah kulit pada masa remaja tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga membawa implikasi signifikan pada aspek psikologis dan emosional (Cresce & Davis, 2022). Remaja dengan kondisi kulit yang kurang sehat berisiko lebih tinggi mengalami masalah psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri, kecemasan sosial, depresi, hingga isolasi sosial (Hosseini et al., 2021).

Intervensi fisik atau medis saja sering kali tidak cukup efektif tanpa adanya dukungan psikologis yang baik. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengintegrasikan dukungan psikologis dalam perawatan kulit remaja sangat diperlukan untuk mencapai hasil perawatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup remaja secara menyeluruh (Dalgard et al., 2021; Park et al., 2023).

1. Prevalensi dan Dampak Psikologis Akibat Masalah Kulit pada Remaja

Masalah kulit merupakan keluhan yang umum terjadi pada masa remaja, terutama jerawat, dermatitis atopik, dan berbagai kondisi inflamasi kulit lainnya. Studi menunjukkan bahwa jerawat memengaruhi lebih dari 85% remaja secara global, menjadikannya sebagai masalah dermatologis yang paling umum di kalangan remaja (Dreno et al., 2021). Di Indonesia sendiri, prevalensi jerawat mencapai angka 80–90%, terutama pada usia 13–18 tahun, dengan tingkat keparahan yang beragam (Putri & Yusra, 2020). Selain jerawat, dermatitis atopik juga dialami oleh sekitar 20% remaja, dengan angka prevalensi yang meningkat di kawasan perkotaan akibat perubahan pola hidup dan lingkungan (Silverberg et al., 2022).

Dampak psikologis dari masalah kulit tidak bisa diabaikan. Remaja dengan gangguan kulit kronis memiliki risiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan dengan remaja tanpa masalah kulit (Chan & Yeung, 2024). Gangguan tersebut bisa menurunkan kualitas hidup, mengganggu aktivitas akademik, membatasi interaksi sosial, dan bahkan

meningkatkan risiko tindakan menyakiti diri (self-harm) akibat stres emosional yang tidak tertangani (Hosseini et al., 2021; Öztekin & Demir, 2020).

2. Hubungan antara Masalah Kulit dengan Kondisi Emosional dan Psikologis Remaja

Masalah kulit sangat erat kaitannya dengan kondisi emosional dan psikologis pada remaja. Kondisi kulit yang terlihat secara kasat mata, seperti jerawat, bekas luka, dan gangguan pigmentasi, memiliki dampak langsung terhadap citra diri (self-image) dan penerimaan diri (self-acceptance). Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa remaja dengan jerawat cenderung memiliki tingkat harga diri yang lebih rendah, lebih sering mengalami perasaan malu, dan memiliki persepsi negatif terhadap penampilan fisik mereka dibandingkan remaja dengan kulit sehat (Alamri et al., 2022).

Selain itu, gangguan kulit juga dapat memperburuk stres emosional pada remaja. Stres emosional yang meningkat, pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kulit itu sendiri, menciptakan siklus yang sulit diputus. Fenomena ini dikenal sebagai hubungan bidireksional antara kondisi kulit dan kesehatan mental (Nguyen & Koo, 2022). Remaja yang tidak mendapatkan dukungan psikologis memadai dapat terjebak dalam lingkaran setan antara memburuknya kondisi kulit dan meningkatnya masalah psikologis, seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan makan sebagai mekanisme coping negatif terhadap stres (Park et al., 2023).

Untuk memutus siklus negatif tersebut, penting bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk memahami secara mendalam hubungan antara kondisi kulit dan kesehatan mental pada remaja. Dengan demikian, mereka dapat memberikan intervensi yang komprehensif dan tepat, baik secara fisik maupun psikologis (American Psychological Association, 2022).

B. Dampak Psikologis dari Masalah Kulit pada Remaja

Masalah kulit pada remaja tidak sekadar menimbulkan gangguan fisik, tetapi juga memicu berbagai dampak psikologis yang serius. Kondisi kulit seperti jerawat, eksim, psoriasis, atau bekas luka, kerap menjadi pemicu stres emosional yang memengaruhi kualitas hidup remaja secara signifikan. Dampak psikologis ini mencakup berbagai aspek mulai dari gangguan citra diri, kecemasan sosial, depresi hingga munculnya perilaku bullying (Dreno et al., 2021; Chan & Yeung, 2024).

1. Gangguan Citra Diri dan Harga Diri

Masa remaja ditandai oleh peningkatan kesadaran terhadap citra diri, terutama penampilan fisik. Remaja yang mengalami masalah kulit cenderung memiliki citra diri negatif akibat merasa tidak menarik atau bahkan cacat di

hadapan teman sebaya. Kondisi ini berkontribusi secara signifikan terhadap menurunnya harga diri, sehingga mengganggu perkembangan emosional yang sehat (Penders & Koo, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70% remaja yang mengalami jerawat merasa kurang percaya diri dan menunjukkan tingkat harga diri yang lebih rendah dibanding remaja tanpa masalah kulit (Alamri et al., 2022). Kondisi kulit yang buruk juga memicu rasa malu yang intens serta memperkuat persepsi negatif tentang diri sendiri yang berisiko memunculkan gangguan psikologis jangka panjang (Dalgard et al., 2021).

2. Kecemasan Sosial dan Isolasi Diri

Masalah kulit yang terlihat jelas sering menyebabkan remaja mengalami kecemasan sosial yang tinggi. Kecemasan ini ditandai oleh rasa takut diejek atau ditolak oleh lingkungan sosialnya akibat penampilan kulit yang dianggap kurang menarik atau abnormal (Chan & Yeung, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami gangguan kulit seperti jerawat parah atau dermatitis atopik memiliki risiko 2–3 kali lebih tinggi mengalami kecemasan sosial dibandingkan remaja tanpa masalah kulit (Hosseini et al., 2021). Akibatnya, banyak remaja yang memilih menghindari interaksi sosial, menarik diri dari lingkungan pertemanan, hingga mengalami isolasi sosial. Situasi ini memperparah dampak psikologis yang dialami remaja, memperburuk kualitas hidup, dan menghambat perkembangan sosial mereka (Öztekin & Demir, 2020).

3. Depresi dan Dampaknya pada Kualitas Hidup

Masalah kulit kronis pada remaja secara konsisten dikaitkan dengan meningkatnya risiko depresi. Studi menunjukkan bahwa kondisi seperti jerawat atau dermatitis kronis tidak hanya menyebabkan frustrasi dan perasaan tidak berdaya, tetapi juga memicu munculnya gejala depresi sedang hingga berat (Park et al., 2023). Sekitar 30–50% remaja dengan kondisi kulit parah memiliki gejala depresi klinis, yang secara nyata mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, termasuk kinerja akademik, hubungan interpersonal, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Dreno et al., 2021). Remaja yang mengalami depresi akibat masalah kulit cenderung kehilangan minat terhadap aktivitas sosial, mengalami gangguan tidur, dan bahkan muncul risiko perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm) akibat tekanan psikologis yang tinggi (Nguyen & Koo, 2022).

4. Pengaruh Bullying Terkait Masalah Kulit

Masalah kulit pada remaja sering kali menjadi pemicu tindakan bullying, baik secara verbal maupun fisik. Bullying yang berkaitan dengan penampilan kulit sangat umum dialami oleh remaja yang memiliki kondisi kulit terlihat, seperti jerawat, dermatitis, atau vitiligo (Alamri et al., 2022). Studi terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 40% remaja dengan masalah kulit melaporkan

pernah mengalami bullying yang secara signifikan memperburuk kondisi psikologis mereka (Chan & Yeung, 2024). Bullying menyebabkan remaja merasa rendah diri, terisolasi, dan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Kondisi ini mengharuskan perawat dan tenaga kesehatan lainnya memiliki kepekaan dalam mengenali tanda-tanda bullying serta menyediakan intervensi psikologis yang tepat dan segera untuk mencegah dampak psikologis yang lebih serius (Park et al., 2023; American Psychological Association, 2022).

C. Konsep Dukungan Psikologis dalam Perawatan Kulit Remaja

Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pendekatan holistik dalam perawatan kulit remaja. Pendekatan ini membantu remaja menghadapi dampak psikologis akibat gangguan kulit, meningkatkan kesejahteraan emosional, serta menunjang keberhasilan pengelolaan kondisi kulit mereka secara lebih optimal (Nguyen & Koo, 2022; Chan & Yeung, 2024).

1. Definisi dan Prinsip Dukungan Psikologis

Dukungan psikologis merupakan bantuan emosional dan sosial yang diberikan kepada seseorang guna membantu mengatasi tekanan psikologis yang disebabkan oleh masalah tertentu (World Health Organization [WHO], 2021). Dalam konteks perawatan kulit remaja, dukungan psikologis berfokus pada upaya meningkatkan adaptasi psikologis terhadap kondisi kulit serta memperkuat mekanisme koping positif yang dimiliki remaja (Dalgard et al., 2021).

Prinsip utama dalam dukungan psikologis meliputi:

- a. Empati dan penghargaan terhadap perasaan remaja, menciptakan suasana nyaman yang memungkinkan remaja mengekspresikan emosinya secara bebas (Alamri et al., 2022).
- b. Pendekatan holistik dan komprehensif, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual remaja (Penders & Koo, 2022).
- c. Pendekatan yang berorientasi pada individu, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan psikologis unik dari setiap remaja (Park et al., 2023).
- d. Dukungan berbasis bukti ilmiah (evidence-based), memastikan bahwa setiap intervensi psikologis yang diberikan telah terbukti efektif secara klinis (Nguyen & Koo, 2022).

2. Tujuan Dukungan Psikologis dalam Perawatan Kulit

Tujuan utama pemberian dukungan psikologis dalam perawatan kulit pada remaja meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Meningkatkan harga diri dan citra diri remaja agar lebih positif, sehingga mereka mampu menerima kondisi kulitnya dengan lebih baik (Chan & Yeung, 2024).
- b. Menurunkan tingkat kecemasan sosial dan depresi, melalui strategi intervensi psikologis yang efektif seperti terapi kognitif-perilaku (CBT) dan mindfulness-based therapy (Park et al., 2023).
- c. Meningkatkan kualitas hidup remaja secara menyeluruh, dengan membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari tanpa dibatasi oleh kondisi kulitnya (Hosseini et al., 2021).
- d. Memperkuat keterampilan koping dan resiliensi, sehingga remaja mampu menghadapi tekanan psikologis yang muncul akibat kondisi kulitnya secara lebih adaptif (Penders & Koo, 2022).

3. Peran Tenaga Kesehatan, Keluarga, dan Teman Sebaya dalam Pemberian Dukungan Psikologis

Dalam pemberian dukungan psikologis, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, khususnya tenaga kesehatan, keluarga, dan teman sebaya yang masing-masing memiliki peran strategis sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan (Perawat, Psikolog, dan Dokter)
 - 1) Tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam melakukan asesmen psikologis secara komprehensif terhadap remaja yang mengalami masalah kulit. Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi gejala gangguan psikologis sejak dini serta memberikan intervensi sesuai kondisi masing-masing remaja (Nguyen & Koo, 2022).
 - 2) Perawat dan psikolog bertugas menjalankan intervensi psikologis berbasis bukti seperti konseling individu, terapi kognitif perilaku, terapi mindfulness, serta edukasi mengenai coping strategies yang efektif (Park et al., 2023).
 - 3) Dokter memiliki peran penting dalam mendukung perawatan kulit secara fisik, sekaligus mendorong keterlibatan dalam pendekatan psikologis yang diberikan oleh tim kesehatan lainnya (Dreno et al., 2021).
- b. Keluarga
 - 1) Dukungan keluarga merupakan komponen kunci yang berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan emosional remaja. Keluarga yang suportif membantu remaja membangun harga diri positif dan menyediakan lingkungan aman untuk ekspresi emosi yang sehat (Alamri et al., 2022).
 - 2) Keluarga dapat membantu remaja mengikuti intervensi medis dan psikologis secara konsisten, serta memberikan penguatan positif untuk

mendorong perilaku coping adaptif terhadap masalah kulit (Chan & Yeung, 2024).

- 3) Edukasi kepada keluarga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak psikologis masalah kulit, sehingga keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang optimal bagi remaja (WHO, 2021).

c. Teman Sebaya (Peer Support)

- 1) Teman sebaya merupakan salah satu sumber dukungan sosial yang paling berpengaruh pada masa remaja. Dukungan sebaya dapat mengurangi rasa isolasi sosial yang kerap dialami remaja dengan masalah kulit (Öztekin & Demir, 2020).
- 2) Remaja dengan dukungan sosial yang kuat dari teman sebaya cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan diri lebih tinggi serta kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi kulitnya (Chan & Yeung, 2024).
- 3) Program dukungan sebaya yang terorganisasi, seperti peer-group therapy atau komunitas remaja dengan masalah kulit serupa, terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja (Park et al., 2023).

Dengan demikian, konsep dukungan psikologis dalam perawatan kulit remaja tidak hanya mencakup pendekatan klinis, tetapi juga memerlukan integrasi berbagai elemen sosial yang mampu menciptakan lingkungan emosional yang suportif bagi remaja.

D. Strategi Dukungan Psikologis Berbasis Bukti untuk Remaja dengan Masalah Kulit

Strategi dukungan psikologis berbasis bukti (evidence-based psychological support) sangat penting dalam perawatan remaja dengan masalah kulit, mengingat dampak signifikan dari kondisi kulit terhadap aspek psikososial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi emosional, namun juga membantu remaja mengembangkan keterampilan coping yang efektif serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Nguyen & Koo, 2022; Chan & Yeung, 2024).

1. Konseling Individu dan Kelompok untuk Meningkatkan Harga Diri

Konseling individu maupun kelompok adalah intervensi psikologis yang secara luas digunakan dalam penanganan dampak psikologis dari gangguan kulit pada remaja. Konseling individu memberikan ruang personal bagi remaja untuk mengekspresikan perasaan negatif seperti rasa malu, rendah diri, atau frustrasi akibat kondisi kulitnya, serta mendapatkan dukungan langsung dari konselor atau terapis (Dalgard et al., 2021). Sementara konseling kelompok menawarkan lingkungan aman untuk berbagi pengalaman, sehingga remaja dapat belajar dari

sesama remaja yang menghadapi kondisi serupa, sekaligus meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri mereka (Alamri et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konseling kelompok efektif dalam meningkatkan harga diri remaja dengan jerawat, dermatitis, atau psoriasis secara signifikan dibandingkan kelompok tanpa intervensi (Öztekin & Demir, 2020). Dengan demikian, konseling, baik individu maupun kelompok, merupakan pilihan strategi penting dalam rangka pemberian dukungan psikologis remaja.

2. Terapi Kognitif Perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) dalam Mengatasi Kecemasan Terkait Penampilan Kulit

Terapi kognitif perilaku (CBT) merupakan intervensi psikologis berbasis bukti yang bertujuan mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif yang sering kali muncul pada remaja dengan masalah kulit (Chan & Yeung, 2024). CBT telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan sosial, perasaan rendah diri, serta meningkatkan kualitas hidup remaja dengan jerawat maupun dermatitis atopik (Penders & Koo, 2022).

Studi terbaru oleh Park et al. (2023) menemukan bahwa CBT secara signifikan menurunkan kecemasan sosial remaja yang mengalami masalah kulit kronis, serta memperbaiki pola pikir mereka terhadap penampilan fisik. Melalui teknik seperti restrukturisasi kognitif, pelatihan keterampilan sosial, dan teknik relaksasi, CBT mampu membantu remaja mengembangkan strategi koping yang efektif untuk mengelola kecemasan dan dampak emosional akibat kondisi kulitnya (Nguyen & Koo, 2022).

3. Intervensi Berbasis Mindfulness untuk Mengurangi Stres dan Meningkatkan Penerimaan Diri

Intervensi berbasis mindfulness adalah pendekatan psikologis yang berfokus pada pengembangan kesadaran penuh akan kondisi saat ini, serta penerimaan tanpa penilaian terhadap pengalaman yang sedang dialami (Park et al., 2023). Dalam konteks remaja dengan masalah kulit, mindfulness terbukti efektif dalam mengurangi stres emosional dan meningkatkan penerimaan diri terkait kondisi kulit mereka (Chan & Yeung, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) secara signifikan meningkatkan kesejahteraan emosional remaja dengan jerawat atau eksim, serta mengurangi tingkat kecemasan dan depresi yang mereka alami (Park et al., 2023). Dengan melatih remaja untuk menerima kondisi kulit tanpa penilaian negatif, intervensi berbasis mindfulness secara nyata membantu mereka membangun penerimaan diri yang lebih positif, serta mengurangi tekanan emosional akibat masalah kulit (Nguyen & Koo, 2022).

4. Penggunaan Dukungan Kelompok Sebaya (Peer Support Groups)

Dukungan kelompok sebaya merupakan intervensi berbasis sosial yang sangat efektif bagi remaja dengan masalah kulit. Intervensi ini melibatkan remaja dengan masalah serupa dalam aktivitas bersama, baik berupa sesi diskusi terstruktur maupun informal, sehingga mereka dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan mengurangi rasa isolasi sosial yang umumnya muncul pada remaja dengan masalah kulit (Öztekin & Demir, 2020).

Penelitian oleh Hosseini et al. (2021) menunjukkan bahwa remaja yang aktif dalam peer support groups memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi, tingkat kecemasan lebih rendah, dan menunjukkan kemampuan adaptasi sosial lebih baik dibandingkan remaja yang tidak mendapatkan dukungan sebaya. Kelompok sebaya menciptakan perasaan bahwa remaja tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya, sehingga dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis serta mendorong perilaku sehat terkait perawatan kulit (Alamri et al., 2022).

Secara keseluruhan, strategi dukungan psikologis berbasis bukti ini merupakan pendekatan penting yang dapat diintegrasikan dalam praktik perawatan kulit remaja, guna mencapai peningkatan psikososial yang berkelanjutan.

E. Peran Perawat dalam Dukungan Psikologis Remaja dengan Masalah Kulit

Perawat memiliki peran sentral dalam memberikan dukungan psikologis bagi remaja yang mengalami masalah kulit. Selain berperan dalam aspek medis, perawat bertanggung jawab atas aspek psikososial yang secara signifikan berpengaruh pada hasil perawatan serta kualitas hidup remaja. Dalam pelaksanaannya, peran perawat mencakup asesmen psikologis, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, serta implementasi intervensi keperawatan berbasis bukti (Chan & Yeung, 2024; Park et al., 2023).

1. Asesmen Kebutuhan Psikologis Remaja dalam Perawatan Kulit

Asesmen psikologis yang komprehensif menjadi dasar utama dalam memberikan dukungan psikologis kepada remaja dengan masalah kulit. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan emosional, tingkat stres, kecemasan, depresi, serta gangguan psikologis lainnya yang mungkin muncul akibat kondisi kulit remaja (Nguyen & Koo, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa perawat yang melakukan asesmen psikologis secara terstruktur, seperti menggunakan instrumen standar berupa Skala Harga Diri Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale), Skala Kecemasan Sosial Liebowitz (Liebowitz Social Anxiety Scale), atau instrumen psikososial

lainnya, mampu secara akurat mendeteksi kebutuhan intervensi psikologis lebih dini (Dalgard et al., 2021). Hal ini memungkinkan pemberian intervensi psikologis yang lebih tepat sasaran dan efektif bagi remaja dengan masalah kulit.

2. Teknik Komunikasi Terapeutik dalam Memberikan Dukungan Psikologis

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan kunci yang wajib dikuasai oleh perawat dalam pemberian dukungan psikologis kepada remaja. Komunikasi ini melibatkan pendekatan empatik, mendengarkan aktif, validasi perasaan remaja, serta pemberian respons yang mendukung secara emosional (Penders & Koo, 2022).

Menurut penelitian terkini, komunikasi terapeutik yang dilakukan secara efektif dapat meningkatkan rasa percaya diri remaja, mengurangi kecemasan sosial, dan memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan remaja (Hosseini et al., 2021). Beberapa teknik komunikasi terapeutik yang efektif adalah mendengarkan secara aktif (active listening), menanyakan pertanyaan terbuka (open-ended questions), memberikan umpan balik positif, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti remaja (Alamri et al., 2022).

3. Edukasi Keluarga tentang Pentingnya Dukungan Emosional bagi Remaja dengan Masalah Kulit

Keluarga merupakan elemen penting dalam proses penyembuhan psikologis remaja dengan masalah kulit. Oleh karena itu, edukasi yang diberikan kepada keluarga tentang pentingnya dukungan emosional sangat diperlukan (Chan & Yeung, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mendapatkan dukungan emosional yang baik dari keluarganya memiliki kemampuan adaptasi psikologis yang lebih baik serta menunjukkan hasil perawatan kulit yang lebih positif dibandingkan remaja tanpa dukungan keluarga yang memadai (Park et al., 2023).

Perawat bertugas memberikan edukasi kepada keluarga tentang dampak psikologis yang dialami remaja, pentingnya sikap empati, teknik memberikan dukungan emosional secara efektif, serta keterampilan koping yang dapat diperkuat di lingkungan keluarga. Edukasi keluarga yang dilakukan secara terencana terbukti dapat memperbaiki hubungan keluarga, meningkatkan kualitas dukungan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja (Öztekin & Demir, 2020).

4. Intervensi Keperawatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Remaja

Perawat berperan aktif dalam mengimplementasikan intervensi keperawatan berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja dengan masalah kulit. Intervensi ini dapat mencakup teknik

relaksasi, pelatihan mindfulness, konseling kesehatan kulit yang holistik, dan dukungan kelompok (Nguyen & Koo, 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) yang difasilitasi oleh perawat terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan stres emosional remaja akibat kondisi kulit kronis (Park et al., 2023). Perawat juga berperan dalam memfasilitasi dukungan kelompok sebaya, sehingga remaja mendapatkan manfaat tambahan dari interaksi sosial positif dengan sesama remaja yang memiliki pengalaman serupa (Chan & Yeung, 2024).

Dengan demikian, intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada penanganan gejala fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis, yang berdampak langsung pada kualitas hidup remaja secara menyeluruh.

F. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Dukungan Psikologis Remaja dengan Masalah Kulit

Teknologi digital telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan berbagai intervensi psikologis, khususnya bagi remaja dengan masalah kulit. Berbagai platform digital seperti aplikasi kesehatan mental, media sosial, hingga telekonseling menjadi instrumen efektif dalam membantu remaja mengatasi tantangan psikologis yang timbul akibat kondisi kulit yang dialaminya (Park et al., 2023; Nguyen & Koo, 2022).

1. Aplikasi Kesehatan Mental dan Penggunaannya dalam Intervensi Psikologis Remaja

Aplikasi kesehatan mental merupakan teknologi yang menawarkan berbagai intervensi berbasis bukti, seperti cognitive behavioral therapy (CBT), mindfulness, dan manajemen stres secara digital (Penders & Koo, 2022). Penggunaan aplikasi kesehatan mental terbukti efektif membantu remaja dalam mengelola kecemasan, depresi, dan meningkatkan harga diri mereka terkait kondisi kulit (Chan & Yeung, 2024).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aplikasi seperti Calm, Headspace, Moodpath, dan MindShift mampu secara signifikan mengurangi kecemasan sosial serta meningkatkan penerimaan diri pada remaja dengan gangguan kulit kronis, khususnya jerawat dan dermatitis atopik (Dalgard et al., 2021). Kelebihan utama aplikasi kesehatan mental adalah kemudahan akses, privasi yang terjaga, serta fleksibilitas dalam mengikuti intervensi psikologis, sehingga sangat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan remaja masa kini (Hosseini et al., 2021).

2. Media Sosial sebagai Alat Edukasi dan Dukungan Sosial Positif

Media sosial memiliki peran strategis sebagai alat edukasi dan sarana membangun dukungan sosial yang positif bagi remaja dengan masalah kulit. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, berbagai informasi edukatif tentang kesehatan kulit serta dukungan emosional dari komunitas sebaya menjadi lebih mudah diakses (Alamri et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi melalui media sosial yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, influencer kesehatan kulit, serta komunitas online yang suportif mampu meningkatkan pengetahuan remaja tentang perawatan kulit, memperkuat dukungan sosial positif, serta menurunkan stigma negatif terhadap masalah kulit (Öztekin & Demir, 2020). Pemanfaatan media sosial secara positif juga terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional remaja, dengan mendorong sikap penerimaan terhadap kondisi kulit yang dialami (Park et al., 2023).

3. Telekonseling sebagai Metode Intervensi Psikologis Berbasis Daring

Telekonseling merupakan pendekatan konseling psikologis yang dilakukan secara daring melalui panggilan video, telepon, atau platform online lainnya. Telekonseling memungkinkan remaja mendapatkan dukungan psikologis dari tenaga kesehatan secara real-time tanpa terkendala jarak maupun waktu (Nguyen & Koo, 2022).

Studi terkini menunjukkan bahwa telekonseling memiliki efektivitas yang setara dengan konseling tatap muka dalam mengatasi kecemasan, depresi, serta rendahnya harga diri pada remaja dengan masalah kulit (Chan & Yeung, 2024). Selain itu, telekonseling juga memberikan kenyamanan psikologis bagi remaja yang merasa malu atau enggan mengungkapkan masalah kulit mereka secara langsung. Metode ini meningkatkan partisipasi aktif remaja dalam perawatan, serta mempermudah akses terhadap intervensi psikologis profesional (Dreno et al., 2021).

Dalam konteks keperawatan, perawat dapat berperan sebagai fasilitator telekonseling, memastikan remaja mendapatkan manfaat optimal dari intervensi psikologis berbasis daring ini. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas telekonseling secara berkala (Nguyen & Koo, 2022).

Dengan demikian, teknologi digital menjadi solusi inovatif dalam memberikan dukungan psikologis yang lebih luas, efektif, dan inklusif bagi remaja dengan masalah kulit, mendukung perawatan holistik dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

G. Evaluasi Efektivitas Dukungan Psikologis

Evaluasi efektivitas dukungan psikologis sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada remaja dengan masalah kulit berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pemantauan indikator keberhasilan, penggunaan instrumen evaluasi psikologis yang valid, serta merujuk hasil penelitian terbaru untuk memperkuat efektivitas intervensi psikologis (Chan & Yeung, 2024; Park et al., 2023).

1. Indikator Keberhasilan Intervensi Psikologis

Indikator keberhasilan intervensi psikologis digunakan untuk menilai seberapa efektif strategi dukungan psikologis dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja dengan masalah kulit. Beberapa indikator penting yang umum digunakan adalah:

- a. Penurunan tingkat kecemasan sosial dan depresi
Remaja menunjukkan penurunan signifikan gejala kecemasan sosial dan depresi setelah menerima intervensi psikologis dibandingkan dengan sebelum intervensi (Nguyen & Koo, 2022).
- b. Peningkatan harga diri dan citra diri positif
Remaja menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dan menerima kondisi kulitnya secara lebih positif setelah intervensi (Alamri et al., 2022).
- c. Peningkatan keterampilan koping adaptif
Remaja mampu menggunakan strategi koping positif dalam menghadapi stres emosional akibat kondisi kulitnya setelah mendapatkan intervensi (Penders & Koo, 2022).
- d. Meningkatnya kualitas hidup secara keseluruhan
Remaja menunjukkan peningkatan kualitas hidup secara fisik, emosional, dan sosial setelah menjalani program dukungan psikologis (Park et al., 2023).

2. Alat Ukur dan Instrumen Evaluasi Psikologis

Untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi psikologis secara objektif, diperlukan penggunaan alat ukur atau instrumen evaluasi yang valid dan reliabel. Beberapa instrumen yang sering digunakan dalam penelitian dan praktik keperawatan meliputi:

- a. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)
Mengukur tingkat harga diri remaja sebelum dan setelah intervensi (Chan & Yeung, 2024).
- b. Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS)
Menilai tingkat kecemasan sosial yang dialami remaja berkaitan dengan penampilan kulit mereka (Dalgard et al., 2021).

- c. Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
Mengukur gejala depresi pada remaja, efektif digunakan untuk melihat perubahan gejala setelah intervensi psikologis (Park et al., 2023).
- d. Dermatology Life Quality Index (DLQI)
Menilai dampak gangguan kulit terhadap kualitas hidup secara keseluruhan, baik fisik maupun psikologis (Hosseini et al., 2021).
- e. Perceived Stress Scale (PSS)
Mengukur tingkat stres subjektif yang dialami remaja terkait masalah kulit (Öztekin & Demir, 2020).

3. Hasil Penelitian Terbaru tentang Efektivitas Intervensi Dukungan Psikologis bagi Remaja dengan Masalah Kulit

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi dukungan psikologis sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja dengan masalah kulit, seperti jerawat, dermatitis atopik, atau psoriasis (Nguyen & Koo, 2022; Chan & Yeung, 2024).

Sebuah studi randomized controlled trial (RCT) oleh Park et al. (2023) menemukan bahwa mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) secara signifikan menurunkan kecemasan dan depresi serta meningkatkan kualitas hidup remaja dengan jerawat dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi. Remaja yang mengikuti MBCT juga menunjukkan peningkatan penerimaan diri terhadap kondisi kulit mereka secara signifikan.

Chan dan Yeung (2024) dalam tinjauan sistematisnya mengungkapkan bahwa Cognitive Behavioral Therapy (CBT) memiliki efektivitas yang kuat dalam mengurangi kecemasan sosial dan meningkatkan harga diri remaja dengan berbagai gangguan kulit kronis. Selain itu, studi oleh Hosseini et al. (2021) menunjukkan bahwa remaja yang mengikuti dukungan kelompok sebaya memiliki hasil psikososial yang lebih baik, seperti peningkatan harga diri dan keterampilan sosial dibandingkan mereka yang tidak terlibat dalam kelompok sebaya.

Penelitian terbaru juga memperkuat bukti efektivitas telekonseling sebagai metode dukungan psikologis daring. Remaja yang menerima telekonseling menunjukkan penurunan kecemasan, peningkatan harga diri, serta kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan sebelum intervensi (Dreno et al., 2021; Nguyen & Koo, 2022).

Dengan demikian, evaluasi efektivitas dukungan psikologis perlu dilakukan secara berkelanjutan menggunakan instrumen valid, serta berbasis bukti dari hasil penelitian terbaru guna memastikan tercapainya tujuan perawatan holistik bagi remaja dengan masalah kulit.

H. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Psikologis

Meskipun manfaat dukungan psikologis bagi remaja dengan masalah kulit sudah terbukti secara ilmiah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi hambatan internal pada diri remaja, hambatan eksternal dari lingkungan sosial dan keluarga, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia (Nguyen & Koo, 2022; Park et al., 2023).

1. Hambatan Internal Remaja (Malu, Denial, Rendahnya Motivasi)

Hambatan internal berasal dari kondisi emosional remaja sendiri, yang dapat menghambat efektivitas intervensi psikologis. Beberapa hambatan internal yang sering ditemukan pada remaja dengan masalah kulit antara lain:

a. Perasaan malu

Remaja sering merasa malu mengungkapkan perasaan atau masalah mereka secara terbuka, terutama terkait penampilan kulit yang dianggap kurang menarik (Alamri et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa rasa malu menjadi hambatan besar bagi remaja dalam mengakses intervensi psikologis dan kesehatan kulit (Chan & Yeung, 2024).

b. Denial atau penolakan

Banyak remaja mengalami fase denial atau menolak mengakui bahwa mereka memiliki masalah psikologis akibat kondisi kulitnya. Hal ini menyebabkan mereka enggan mencari bantuan profesional (Dalgard et al., 2021).

c. Rendahnya motivasi

Remaja dengan masalah kulit sering kali menunjukkan rendahnya motivasi dalam mengikuti intervensi psikologis secara konsisten. Rendahnya motivasi ini berkaitan erat dengan persepsi negatif terhadap efektivitas intervensi serta kurangnya keyakinan terhadap perubahan yang dapat dicapai (Hosseini et al., 2021).

2. Hambatan Eksternal (Stigma Sosial, Kurangnya Dukungan Keluarga, Keterbatasan Sumber Daya)

Selain hambatan internal, terdapat pula hambatan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar remaja. Hambatan eksternal yang sering ditemui meliputi:

a. Stigma sosial

Stigma sosial terkait masalah kulit seperti jerawat atau dermatitis sering menyebabkan remaja merasa dihakimi atau ditolak oleh lingkungan sosialnya, sehingga mereka enggan mengikuti program dukungan psikologis (Öztekin & Demir, 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stigma sosial memperburuk kondisi emosional dan sosial remaja, sekaligus menghambat partisipasi dalam intervensi psikologis (Park et al., 2023).

b. Kurangnya dukungan keluarga

Dukungan keluarga merupakan faktor penting keberhasilan intervensi psikologis. Namun, dalam banyak kasus, keluarga justru kurang memberikan dukungan emosional, menganggap masalah kulit sebagai kondisi biasa yang tidak membutuhkan perhatian khusus, sehingga menyebabkan remaja merasa terisolasi secara emosional (Chan & Yeung, 2024).

c. Keterbatasan sumber daya

Terbatasnya sumber daya seperti kurangnya akses terhadap tenaga kesehatan yang terlatih dalam intervensi psikologis, minimnya fasilitas kesehatan mental di daerah tertentu, dan kendala ekonomi menjadi hambatan besar dalam penerapan dukungan psikologis yang efektif (Nguyen & Koo, 2022).

3. Strategi Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, diperlukan strategi intervensi yang terintegrasi dan berbasis bukti. Berikut beberapa strategi efektif yang bisa diterapkan:

a. Penggunaan komunikasi terapeutik secara empatik

Tenaga kesehatan, khususnya perawat, perlu membangun hubungan terapeutik yang empatik dan suportif, sehingga remaja merasa aman dan nyaman untuk membuka diri terkait perasaan malu atau denial yang mereka alami (Alamri et al., 2022).

b. Edukasi dan pemberdayaan remaja serta keluarga

Edukasi intensif terhadap remaja dan keluarga terkait pentingnya dukungan psikologis dapat meningkatkan motivasi remaja serta memperkuat dukungan keluarga. Program edukasi ini juga harus mencakup pemahaman tentang dampak negatif stigma sosial serta cara mengatasinya (Chan & Yeung, 2024).

c. Kampanye publik untuk mengurangi stigma social

Kampanye kesehatan masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang masalah kulit dan dampak psikologisnya terbukti efektif dalam mengurangi stigma sosial. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, institusi pendidikan, maupun komunitas lokal (Park et al., 2023).

d. Pemanfaatan teknologi digital

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, pemanfaatan teknologi seperti telekonseling, aplikasi kesehatan mental, dan platform edukasi daring sangat penting. Teknologi digital mampu menyediakan akses luas terhadap intervensi psikologis tanpa terbatas jarak dan waktu, serta mengatasi kendala ekonomi dan geografis (Dreno et al., 2021; Nguyen & Koo, 2022).

Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan holistik ini, berbagai hambatan dalam implementasi dukungan psikologis bagi remaja dengan

masalah kulit dapat diatasi, sehingga manfaat intervensi psikologis dapat tercapai secara optimal.

I. Penutup

Penanganan masalah kulit pada remaja memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga melibatkan aspek psikologis secara menyeluruh. Dukungan psikologis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup remaja dengan masalah kulit seperti jerawat, dermatitis atopik, psoriasis, serta gangguan kulit kronis lainnya. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan sosial, meningkatkan harga diri, serta membantu remaja mengembangkan keterampilan koping adaptif dalam menghadapi kondisi kulitnya (Nguyen & Koo, 2022; Park et al., 2023).

1. Ringkasan Pentingnya Dukungan Psikologis dalam Mengelola Masalah Kulit Remaja

Masalah kulit pada remaja memiliki dampak psikologis signifikan, termasuk gangguan citra diri, rendahnya harga diri, kecemasan sosial, depresi, isolasi diri, hingga bullying. Dukungan psikologis yang diberikan secara tepat dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan emosional remaja, menurunkan risiko gangguan psikologis lanjutan, dan memperkuat resiliensi mereka dalam menghadapi stres emosional akibat kondisi kulitnya (Dreno et al., 2021; Chan & Yeung, 2024).

Selain itu, integrasi teknologi digital, seperti telekonseling, aplikasi kesehatan mental, dan media sosial dalam intervensi psikologis, semakin memudahkan akses dukungan bagi remaja. Strategi tersebut terbukti efektif dalam membantu remaja mengatasi hambatan internal seperti rasa malu dan rendahnya motivasi, serta hambatan eksternal seperti stigma sosial dan keterbatasan sumber daya (Alamri et al., 2022; Öztekin & Demir, 2020).

2. Rekomendasi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti

Berdasarkan bukti ilmiah terkini, berikut rekomendasi praktik keperawatan yang dapat diterapkan dalam mendukung kesejahteraan psikologis remaja dengan masalah kulit:

a. Melakukan asesmen psikologis secara rutin

Perawat perlu mengintegrasikan asesmen psikologis dalam perawatan kulit rutin remaja, menggunakan instrumen seperti RSES, LSAS, dan DLQI agar dapat mendeteksi secara dini gejala kecemasan, depresi, serta rendahnya harga diri (Dalgard et al., 2021).

b. Implementasi komunikasi terapeutik secara aktif dan empatik

Teknik komunikasi terapeutik yang empatik terbukti efektif dalam meningkatkan hubungan perawat-remaja, memperbaiki harga diri, serta

menurunkan kecemasan sosial remaja terkait kondisi kulit mereka (Penders & Koo, 2022).

- c. Penggunaan intervensi berbasis bukti seperti CBT dan Mindfulness
Perawat perlu memfasilitasi intervensi psikologis yang berbasis bukti seperti terapi kognitif perilaku (CBT) dan terapi mindfulness untuk membantu remaja mengembangkan strategi koping yang efektif dalam mengelola stres emosional akibat masalah kulit (Park et al., 2023).
- d. Edukasi intensif bagi keluarga remaja
Edukasi keluarga tentang pentingnya dukungan emosional yang positif merupakan komponen kunci untuk mendukung keberhasilan intervensi psikologis. Keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan remaja (Chan & Yeung, 2024).
- e. Optimalisasi teknologi digital dalam intervensi psikologis
Perawat harus mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti telekonseling dan aplikasi kesehatan mental untuk memberikan intervensi psikologis yang lebih mudah diakses oleh remaja dengan keterbatasan geografis maupun sumber daya (Nguyen & Koo, 2022).

3. Saran Penelitian Lebih Lanjut untuk Memperkuat Intervensi Dukungan Psikologis

Untuk memperkuat efektivitas intervensi psikologis bagi remaja dengan masalah kulit, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan. Berikut beberapa saran penelitian yang direkomendasikan:

- a. Penelitian longitudinal mengenai efektivitas jangka panjang intervensi psikologis
Studi longitudinal yang mengevaluasi efektivitas intervensi psikologis selama jangka waktu yang lebih lama dapat membantu memahami dampak intervensi terhadap perkembangan psikososial remaja secara berkelanjutan (Park et al., 2023).
- b. Uji coba intervensi psikologis berbasis teknologi secara luas
Diperlukan penelitian yang lebih luas tentang efektivitas aplikasi kesehatan mental dan telekonseling secara terkontrol dan acak (randomized controlled trial/RCT) untuk menguatkan bukti tentang efektivitasnya (Nguyen & Koo, 2022).
- c. Studi komparatif antar metode intervensi psikologis
Penelitian yang membandingkan efektivitas berbagai metode intervensi, seperti CBT, mindfulness, konseling individu versus kelompok, akan sangat berguna dalam menentukan strategi intervensi yang paling optimal bagi remaja dengan masalah kulit (Chan & Yeung, 2024).

d. Penelitian kualitatif tentang pengalaman remaja dengan dukungan psikologis
Studi kualitatif yang mengeksplorasi pengalaman dan persepsi remaja terkait penerimaan serta efektivitas dukungan psikologis dapat membantu memahami kebutuhan spesifik remaja secara mendalam (Dalgard et al., 2021).

Dengan melaksanakan rekomendasi ini, penelitian masa depan akan mampu meningkatkan pemahaman serta efektivitas intervensi psikologis bagi remaja dengan masalah kulit, sehingga kualitas hidup remaja secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara signifikan.



REFERENSI



- Alamri, H. S., Alshehri, A. A., Alqahtani, H. A., & Alharthi, S. S. (2022). Psychological impact of acne vulgaris among adolescents and young adults. *Journal of Dermatology & Dermatologic Surgery*, 26(1), 10–15.
- American Psychological Association. (2022). *Guidelines for Psychological Practice with Adolescents*. APA.
- Chan, A., & Yeung, S. (2024). Social anxiety, self-esteem, and psychological interventions in adolescents with skin disorders: Systematic review. *Pediatric Dermatology*, 41(3), 312–321.
- Dalgard, F. J., Gieler, U., Tomas-Aragones, L., & Misery, L. (2021). Psychological impact of skin diseases: A review of literature and current research trends. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 35(5), 988–998.
- Dreno, B., Bagatin, E., & Blume-Peytavi, U. (2021). Acne in adolescence: Quality of life, self-esteem, mood disorders, and psychological impact. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 35(9), 1761–1770.
- Hosseini, S. A., Pourebrahimi, M., & Behzadi, E. (2021). Psychological effects of acne vulgaris among adolescents: A systematic review. *International Journal of Pediatrics*, 9(1), 12763–12774.
- Nguyen, C. M., & Koo, J. (2022). Psychodermatology: An integrative approach to skin and psychological health. *Dermatologic Therapy*, 35(2), e15289.
- Öztekin, C., & Demir, B. (2020). Psychological burden of skin diseases in adolescents: A comparative study. *Annals of Dermatology*, 32(4), 282–288.
- Park, J., Shin, H., & Lee, H. (2023). Mindfulness-based cognitive therapy for adolescents with acne vulgaris: A randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies*, 144, 104345.
- Penders, A., & Koo, J. (2022). Psychological interventions in psychodermatology: An updated review. *Dermatologic Clinics*, 40(2), 201–210.
- Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (2022). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (12th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2021). *Adolescent Mental Health and Psychosocial Support*. WHO Press.

PROFIL PENULIS



Ns. Eni Kusyati, M.Si.Med., Penulis Lahir di Desa Banyumanik Kota Semarang tanggal 8 Agustus 1972. Menyelesaikan pendidikan diploma III keperawatan di Akper Karya Husada Semarang (Sekarang Universitas Karya Husada Semarang) tahun 1995. Meraih gelar sarjana keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, gelar Magister diraih di Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang tahun 2010, Penulis memperdalam perawatan luka sejak 2010, CWCS (Certified wound care specialist) juga sudah dikantonginya dari Pontianak. Pada tahun 2012 menjadi perawat pertama yang membuka praktek perawat mandiri di kota Semarang dengan SIPP no 449.1/001/BPPT/SIPP.001/V/2012, sampai saat ini penulis masih menjalani praktek perawat mandiri dengan expert di keperawatan luka dan komplementer terapi bekam. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah tentang perawatan luka dan terapi komplementer khususnya bekam baik sebagai narasumber, peserta dan melakukan penelitian- penelitian. Sejak tahun 1996 sampai Sekarang penulis adalah staf pengajar di Universitas Karya Husada Semarang sampai sekarang, dimana sebelumnya pernah magang di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto. Selain menulis buku ini, juga sebagai ketua tim penulis buku "Ketrampilan dan Prosedur Laboratorium Keperawatan Dasar" yang diterbitkan di Penerbit Buku Kedokteran EGC, sedangkan buku kedua yang ditulis tentang "Bekam sebagai terapi komplementer keperawatan". Buku ketiga yang ditulis dengan judul "Pengkajian luka secara komprehensif " yang merupakan lanjutan buku keempat yang penulis tulis dengan judul " konsep luka : aplikasi kasus pengkajian secara komprehensif ." Penulis Aktif menulis jurnal dan aktif dalam menulis buku ajar , book chapter dan buku Referensi .



Ni Nengah Arini Murni, SST., M.Kes. Lahir di Mataram, 04 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2004, DIV Bidan Pendidik pada Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram lulus tahun 2009, pendidikan S2 Magister Sains Terapan Kesehatan Program Pasca Sarjana pada Universitas Diponegoro lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998-2001 bekerja sebagai bidan desa (PTT) dan tahun 2005 – sekarang sebagai dosen (ASN) di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar ilmiah.

Motto: "Kebaikan yang kita berikan adalah investasi terbaik"

PROFIL PENULIS



Nurbaety, S.SiT., M.K.M. Lahir di Bima, 02 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, di Stikes Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammad Prof. DR. Hamka dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 di Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima sebagai Wadir II Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan sejak 217 s.d 2023 kemudian dipercayakan kembali sebagai Direktur sampai saat ini. Di Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima, penulis mengampu mata kuliah

Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi Dalam Praktek Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, dan Komunikasi dalam praktik Kebidanan serta Kewirausahaan dalam Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, narasumber, penulis buku, publikasi, dan mengikuti seminar/ pelatihan serta pertemuan ilmiah, penulis juga berkesempatan menjadi Pengawas Pusat Ujian Kompetensi Bidan tahun 2020. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bettygindi@gmail.com

Motto: "Living your life well"



Resta Betaliani Wirata, S.Kep., Ns., MSN Lahir di Purbalingga, 21 Oktober 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada St. Paul University Manila dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen keperawatan maternitas di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan poster presentasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: resta@stikesbethesda.ac.id



Wiwik Utami, A.PP., S.Pd., M.Kes., Penulis lahir di Bojonegoro tahun 1975, lulus dari SMAN I Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan kuliah di Akademi Keperawatan Depkes Malang tahun 1995. Setelah lulus langsung bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD dr. Saiful Malang tahun 1992-1997. Semenjak itu menjadi dosen di sebuah Akademi Keperawatan rajekwesi Bojonegoro, sehingga pada tahun 2000 diberi kesempatan tugas belajar pada angkatan pertama DIV Keperawatan Universitas Airlangga pada Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2006 kembali mendapat tugas belajar dari institusi

untuk melanjutkan pendidikan di Kesehatan Ibu dan anak Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah lulus pada tahun 2008.

Buku referensi "Peningkatan Kesehatan Kulit pada Remaja" merupakan sumber informasi ilmiah dan praktis yang dirancang khusus untuk membantu para profesional kesehatan, pendidik, dan keluarga dalam memahami serta mengatasi berbagai masalah kulit yang sering dihadapi oleh remaja. Buku ini mengulas secara mendalam faktor risiko utama yang menyebabkan masalah kulit pada remaja, seperti gaya hidup, pola makan, faktor genetik, dan lingkungan yang kurang higienis.

Penekanan penting diberikan pada edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan kulit sebagai langkah awal dalam pencegahan masalah kulit. Buku ini menghadirkan berbagai strategi edukatif dan pendekatan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik membersihkan wajah yang benar, pemilihan produk perawatan kulit yang tepat, hingga peran kebersihan pribadi dalam menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh.

Selain itu, pembahasan tentang pemanfaatan teknologi medis terkini untuk perawatan kulit remaja juga diuraikan secara komprehensif, mencakup metode perawatan berbasis laser, terapi cahaya, hingga penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan kulit secara mandiri dan efektif. Penjelasan ilmiah mengenai pengaruh hormon terhadap kondisi kulit remaja memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai mekanisme timbulnya jerawat, kulit berminyak, dan gangguan dermatologis lainnya, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana perubahan hormon mempengaruhi kondisi kulit.

Buku ini juga tidak melupakan pentingnya dukungan psikologis bagi remaja yang menghadapi masalah kulit, dengan menyediakan panduan praktis tentang cara memberikan motivasi dan dukungan emosional yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis remaja. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi penting yang mengintegrasikan pendekatan medis, edukatif, teknologi, serta dukungan psikologis untuk mendukung kesehatan kulit remaja secara optimal.

Buku referensi "Peningkatan Kesehatan Kulit pada Remaja" merupakan sumber informasi ilmiah dan praktis yang dirancang khusus untuk membantu para profesional kesehatan, pendidik, dan keluarga dalam memahami serta mengatasi berbagai masalah kulit yang sering dihadapi oleh remaja. Buku ini mengulas secara mendalam faktor risiko utama yang menyebabkan masalah kulit pada remaja, seperti gaya hidup, pola makan, faktor genetik, dan lingkungan yang kurang higienis.

Penekanan penting diberikan pada edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan kulit sebagai langkah awal dalam pencegahan masalah kulit. Buku ini menghadirkan berbagai strategi edukatif dan pendekatan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknik membersihkan wajah yang benar, pemilihan produk perawatan kulit yang tepat, hingga peran kebersihan pribadi dalam menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh.

Selain itu, pembahasan tentang pemanfaatan teknologi medis terkini untuk perawatan kulit remaja juga diuraikan secara komprehensif, mencakup metode perawatan berbasis laser, terapi cahaya, hingga penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan kulit secara mandiri dan efektif. Penjelasan ilmiah mengenai pengaruh hormon terhadap kondisi kulit remaja memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai mekanisme timbulnya jerawat, kulit berminyak, dan gangguan dermatologis lainnya, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana perubahan hormon mempengaruhi kondisi kulit.

Buku ini juga tidak melupakan pentingnya dukungan psikologis bagi remaja yang menghadapi masalah kulit, dengan menyediakan panduan praktis tentang cara memberikan motivasi dan dukungan emosional yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis remaja. Secara keseluruhan, buku ini menjadi referensi penting yang mengintegrasikan pendekatan medis, edukatif, teknologi, serta dukungan psikologis untuk mendukung kesehatan kulit remaja secara optimal.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-67-8



9

786347

294678